

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU
CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE
FRONTEIRA - MESTRADO**

Meirieli Íside Mattos Carvalho

**ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE GESTANTES QUE DEMANDAM USO DE
ANTICOAGULANTE EM REGIÃO DE FRONTEIRA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Estado do Paraná, na linha de pesquisa Epidemiologia e Vigilância em Saúde de Fronteira.

Orientadora: Prof^{fa}. Dr^a. Adriana Zilly

FOZ DO IGUAÇU – PR
2026

Meirieli Íside Mattos Carvalho

**ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE GESTANTES QUE DEMANDAM USO DE
ANTICOAGULANTE EM REGIÃO DE FRONTEIRA**

Versão Original

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira - Mestrado, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Saúde Pública.

Área de concentração: Saúde Pública em Região de Fronteira

Orientadora: Prof^a. Dra. Adriana Zilly

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Carvalho, Meirielei Íside Mattos Carvalho

Itinerário terapêutico de gestantes que demandam uso de anticoagulante em região de fronteira / Meirielei Íside Mattos Carvalho Carvalho; orientadora Adriana Zilly Zilly. -- Foz do Iguaçu, 2026.

77 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Foz do Iguaçu)
-- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira, 2026.

1. gestante. 2. trombofilia. 3. perda gestacional . 4. anticoagulante. I. Zilly, Adriana Zilly, orient. II. Título.

CARVALHO, M. I. M. **Itinerário terapêutico de gestantes que demandam uso de coagulante em região de fronteira**. 2026. 77p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

Aprovado em: 06/03/2026

Banca Examinadora

Profa. Dra.: **Adriana Zilly**
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE
Julgamento: Orientadora

Assinado digitalmente por
ADRIANA ZILLY
ZILLY:022
69514998
Assinado digitalmente por
ADRIANA ZILLY
ZILLY:022
69514998
Data: 2026.06.24 19:24:11-0300
Certificado Digital
Assinado digitalmente por
ADRIANA ZILLY
ZILLY:022
69514998
Data: 2026.06.24 19:24:11-0300
Certificado Digital

Profa. Dra.: **Ana Paula Contiero**
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná-
UNIOESTE
Julgamento: Membro da banca examinadora

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA CONTIERO
Data: 08/05/2026 16:56:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr.: **Walfrido Kuhl Svoboda**
Instituição: Universidade Federal da Integração Latino-
Americana -UNILA
Julgamento: Membro da banca examinadora

gov.br
Documento assinado digitalmente
WALFRIDO KUHLL SVOBODA
Data: 07/05/2026 11:56:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dedico este trabalho a todas as mulheres que vivenciaram perdas gestacionais decorrentes da trombofilia, cujas trajetórias silenciosas motivam a busca por conhecimento e cuidado mais qualificado. Aos meus filhos: Mathias, que nasceu com 38 semanas de gestação em decorrência de uma trombofilia não diagnosticada, e Samuel, que simboliza minha resiliência e a vitória alcançada por meio do tratamento.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, ao meu marido, Airton, por todo o apoio, incentivo e dedicação à nossa família ao longo desta jornada. Sua parceria, compreensão e presença constante foram fundamentais para que eu pudesse seguir firme diante dos desafios e alcançar esta conquista.

Ao meu filho Samuel, minha maior fonte de coragem e resiliência, agradeço por ser inspiração diária e razão maior para continuar avançando, mesmo nos momentos mais difíceis.

Aos meus pais, Marli e José Arimatea, expresso minha profunda gratidão por serem a base da minha força, dos meus valores e da esperança que me conduziram até aqui. Tudo o que sou carrega os ensinamentos, o amor e o exemplo que recebi de vocês.

À minha amiga Camila, agradeço de forma especial pelo apoio diário nos cuidados com minha família e pela disponibilidade diante das minhas ausências dedicadas aos estudos, contribuição essencial para a realização deste trabalho.

À minha amiga e comadre Regiane Cristina, minha sincera gratidão por estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Seu apoio constante foi e sempre será muito importante para mim.

Aos meus sogros, Márcia e Airton, agradeço o apoio, carinho e cuidado oferecidos durante este último ano de pesquisa, tornando esta caminhada mais leve e acolhedora.

À Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), meu local de trabalho, agradeço o incentivo e apoio à capacitação do corpo técnico. Em especial, à minha chefia imediata, Lourene, pela concessão do afastamento necessário para o cumprimento das disciplinas, e aos meus colegas de trabalho, que gentilmente absorveram a carga de trabalho durante minha ausência.

Aos meus grandes amigos Giseli, Juliana e Fernando, deixo meu sincero agradecimento pelo apoio, incentivo e por me encorajarem a retomar os estudos e seguir em frente nesta trajetória acadêmica.

À minha amiga Carla, agradeço por ter sido o impulso inicial, mostrando-me que eu seria capaz de voltar a estudar e a fazer pesquisa, reacendendo minha confiança nesse caminho.

À minha amiga Cristhiany, agradeço pelo apoio constante e pela dedicação com que participou e executou o projeto de extensão, contribuindo significativamente para esta pesquisa.

Às minhas colegas de turma de mestrado, Erika e Karla, agradeço pelas trocas, pelo compartilhamento de experiências e pelas vivências construídas ao longo dessa caminhada, que

tornaram o percurso mais enriquecedor.

À minha colega Simone Brand, meu agradecimento especial pelo apoio e ajuda fundamentais, especialmente na fase final da dissertação, quando sua colaboração foi essencial.

A todas as mulheres que participaram desta pesquisa, minha profunda gratidão por compartilharem suas histórias e experiências, tornando possível a construção deste estudo e dando sentido a esta investigação.

À minha orientadora e professora de longa data, Adriana Zilly, expresso minha admiração e sincera gratidão pela confiança, incentivo e dedicação ao longo de todo o processo. Sua orientação foi essencial para transformar este trabalho em realidade.

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para esta conquista e fizeram parte desta trajetória.

CARVALHO, M. I. M. **Itinerário terapêutico de gestantes que demandam uso de coagulante em região de fronteira**. 2026. 77p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMO

A trombofilia, condição que predispõe à formação de coágulos sanguíneos, assume maior relevância durante a gestação devido às alterações fisiológicas que favorecem o surgimento de trombos. Gestantes com trombofilia têm risco elevado de complicações, como abortos recorrentes, restrição de crescimento fetal, pré-eclâmpsia e tromboembolismo venoso. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece protocolos para o diagnóstico e tratamento dessas condições, mas o acesso ao tratamento com anticoagulantes, como enoxaparina sódica, é limitado a critérios clínicos e diagnóstico. Em regiões de fronteira, como Foz do Iguaçu, a situação é agravada pela dificuldade de atender gestantes em situação de vulnerabilidade social, muitas das quais enfrentam desafios para se enquadrar nos critérios do protocolo clínico, o que dificulta o acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequados. Este estudo teve como objetivo descrever o itinerário terapêutico (IT) de gestantes que necessitam de tratamento com anticoagulantes em região de fronteira, analisando os desafios enfrentados por essas mulheres e as possíveis consequências desse subdiagnóstico no contexto de um município fronteiriço. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada na análise de conteúdo, conforme Minayo, e conduzida segundo os critérios do *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research* (COREQ). A abordagem teórico-metodológica adotada foi a hermenêutica-dialética. Participaram do estudo 19 mulheres que utilizaram anticoagulante durante a gestação, no período de 2015 a 2025, selecionadas por amostragem não probabilística do tipo bola de neve. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados até o ponto de saturação teórica. Os resultados revelaram itinerários terapêuticos marcados pela naturalização da perda gestacional, fragmentação do cuidado, ausência de longitudinalidade e dificuldades de acesso ao diagnóstico de trombofilia. Evidenciaram-se barreiras institucionais e financeiras para a realização de exames laboratoriais, bem como entraves no acesso oportuno à enoxaparina sódica, frequentemente obtida por meio de judicialização. As especificidades do território de fronteira intensificaram essas dificuldades, sobretudo para mulheres em situação de maior vulnerabilidade. O PCDT, embora normatize o cuidado, apresenta limitações para responder às necessidades de gestantes com quadros clínicos compatíveis com trombofilia, especialmente em contextos fronteiriços. O estudo aponta a necessidade de revisão dos fluxos assistenciais, fortalecimento da atenção primária e formulação de políticas públicas que ampliem o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, contribuindo para a redução de perdas gestacionais evitáveis e para a qualificação do cuidado materno-infantil.

Palavras-chave: Gestante; Trombofilia; Anticoagulante; Perda Gestacional.

CARVALHO, MIM. **Therapeutic Itinerary of Pregnant Women Requiring Anticoagulant Use in a Border Region.** 2026. 77f. Dissertation (master's in public health) – Health Sciences Center, State University of Western Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

ABSTRACT

Thrombophilia, a condition that predisposes to the formation of blood clots, is more relevant during pregnancy due to the physiological changes that favor the appearance of thrombi. Pregnant women with thrombophilia are at high risk of complications, such as recurrent miscarriages, fetal growth restriction, preeclampsia, and venous thromboembolism. In Brazil, the Unified Health System (SUS) offers protocols for the diagnosis and treatment of these conditions, but access to treatment with anticoagulants, such as enoxaparin sodium, is limited to clinical criteria and diagnosis. In border regions, such as Foz do Iguaçu, the situation is aggravated by the difficulty of caring for pregnant women in situations of social vulnerability, many of whom face challenges in meeting the criteria of the clinical protocol, which hinders access to adequate diagnosis and treatment. This study aimed to describe the therapeutic itinerary (TR) of pregnant women who need treatment with anticoagulants in a border region, analyzing the challenges faced by these women and the possible consequences of this underdiagnosis in the context of a border municipality. This is qualitative, exploratory and descriptive research, based on content analysis, according to Minayo, and conducted according to the criteria of the Consolidated Criteria for *Reporting Qualitative Research* (COREQ). The theoretical-methodological approach adopted was hermeneutics-dialectics. The study included 19 women who used anticoagulants during pregnancy, from 2015 to 2025, selected by non-probabilistic snowball sampling. The data were produced through semi-structured interviews and analyzed up to the point of theoretical saturation. The results revealed therapeutic itineraries marked by the naturalization of pregnancy loss, fragmentation of care, lack of longitudinality and difficulties in accessing the diagnosis of thrombophilia. Institutional and financial barriers to performing laboratory tests were evidenced, as well as obstacles to timely access to enoxaparin sodium, often obtained through judicialization. The specificities of the border territory intensified these difficulties, especially for women in situations of greater vulnerability. The PCDT, although it regulates care, has limitations in responding to the needs of pregnant women with clinical conditions compatible with thrombophilia, especially in border contexts. The study points to the need to review care flows, strengthen primary care, and formulate public policies that expand access to diagnosis and treatment, contributing to the reduction of avoidable pregnancy losses and to the qualification of maternal and childcare.

Keywords: Pregnant woman; Thrombophilia; Anticoagulant; Gestational loss.

CARVALHO, MIM. **Itinerario terapéutico de gestantes que requieren el uso de anticoagulantes en una región de frontera.** 2026. 77f. Disertación (Maestría en Salud Publica) – Centro de Ciencias de la Salud, Universidad del Estado del Oeste del Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMEN

La trombofilia, una condición que predispone a la formación de coágulos sanguíneos, es más relevante durante el embarazo debido a los cambios fisiológicos que favorecen la aparición de trombos. Las mujeres embarazadas con trombofilia tienen un alto riesgo de complicaciones, como abortos recurrentes, restricción del crecimiento fetal, preeclampsia y tromboembolismo venoso. En Brasil, el Sistema Unificado de Salud (SUS) ofrece protocolos para el diagnóstico y tratamiento de estas afecciones, pero el acceso al tratamiento con anticoagulantes, como la enoxaparina sódica, se limita a criterios clínicos y diagnóstico. En regiones fronterizas, como Foz do Iguaçu, la situación se agrava por la dificultad de atender a mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad social, muchas de las cuales enfrentan dificultades para cumplir con los criterios del protocolo clínico, lo que dificulta el acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados. Este estudio tuvo como objetivo describir el itinerario terapéutico (TR) de las mujeres embarazadas que necesitan tratamiento con anticoagulantes en una región fronteriza, analizando los desafíos que enfrentan estas mujeres y las posibles consecuencias de este sub-diagnóstico en el contexto de un municipio fronterizo. Se trata de una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva, basada en el análisis de contenidos, según Minayo, y realizada según los criterios de los Criterios Consolidados para *la Investigación Cualitativa* (COREQ). El enfoque teórico-metodológico adoptado fue hermenéutica-dialéctica. El estudio incluyó a 19 mujeres que usaron anticoagulantes durante el embarazo, de 2015 a 2025, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico en bola de nieve. Los datos se produjeron mediante entrevistas semiestructuradas y se analizaron hasta el punto de saturación teórica. Los resultados revelaron itinerarios terapéuticos marcados por la naturalización de la pérdida del embarazo, fragmentación de la atención, falta de longitudinalidad y dificultades para acceder al diagnóstico de trombofilia. Se evidenciaron barreras institucionales y financieras para realizar pruebas de laboratorio, así como obstáculos para el acceso oportuno a la enoxaparina sodio, a menudo obtenidos mediante judicialización. Las especificidades del territorio fronterizo intensificaron estas dificultades, especialmente para mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. El PCDT, aunque regula la atención, tiene limitaciones para responder a las necesidades de mujeres embarazadas con condiciones clínicas compatibles con la trombofilia, especialmente en contextos fronterizos. El estudio señala la necesidad de revisar los flujos de atención, fortalecer la atención primaria y formular políticas públicas que amplíen el acceso al diagnóstico y tratamiento, contribuyendo a la reducción de pérdidas de embarazo evitables y a la cualificación del cuidado materno e infantil.

Palabras clave: Mujer embarazada; Trombofilia; Anticoagulante; Pérdida gestacional.

LISTA DE SIGLAS

AAE – Atenção Ambulatorial Especializada

AAS – Ácido Acetilsalicílico

AC – Análise do Conteúdo

ACS – Agentes Comunitários de Saúde

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

APS – Atenção Primária à Saúde

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa

CIT – Comissão Intergestores Tripartite

CMI – Centro Materno Infantil

CNS – Cartão Nacional de Saúde

COREQ – *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research*

DATASUS – Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde

DOU – Diário Oficial da União

EP – Embolia Pulmonar

E-SUS – Sistema eletrônico do Sistema Único de Saúde

FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia

HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana

IT – Itinerário Terapêutico

MACC – Modelo de Atenção às Condições Crônicas

MS – Ministério da Saúde

PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher

PCDT – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas

PNAISM – Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher

PNF – Política Nacional de Fronteiras

PPGSPRF – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira

RAMI – REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E INFANTIL

RAS – Rede de Atenção À Saúde

RC – Rede Cegonha

SAF – Síndrome Antifosfolípide

SÍNDROME HELLIP – Hemólise, Enzimas Hepáticas Elevadas e Contagem Baixa de Plaquetas

SIS-FRONTTEIRAS – Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras

SMSA – Secretária Municipal de Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TEP – Tromboembolismo Pulmonar

TEV – Tromboembolismo Venoso

TICS – Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde

TVP – Trombose Venosa Profunda

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxograma da prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia	30
Figura 2 – Mapa falado do IT de gestantes que demandam uso de anticoagulantes durante a gestação pela 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu, PR, de 2015 a 2025 : fluxo real e fluxo ideal	50

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características sociodemográficas das participantes do estudo (n = 19) sobre o uso de anticoagulantes durante a gestação na 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu, PR, de 2015 a 2025.	39
Tabela 2 – Características obstétricas e gestacionais das participantes do estudo (n = 19) sobre o uso de anticoagulantes durante a gestação na 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu, PR, de 2015 a 2015.	40

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
2	JUSTIFICATIVA	19
3	OBJETIVO	23
3.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	23
4	QUADRO TEÓRICO	24
4.1	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)	24
4.2	SAÚDE DA MULHER	25
4.3	TROMBOFILIAS	27
4.4	PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT).....	28
4.4.1	Tratamento Profilático	28
4.5	BARREIRAS E DESAFIOS DO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE GESTANTES EM BUSCA DE DIAGNÓSTICO PARA TROMBOFILIA	31
5	MATERIAIS E MÉTODOS	33
5.1	TIPO DE PESQUISA	33
5.2	LOCAL DA PESQUISA	34
5.3	PARTICIPANTES DO ESTUDO	34
5.4	ENTREVISTA.....	35
5.5	ANÁLISE DOS DADOS.....	36
5.6	ASPECTOS ÉTICOS	37
5.7	RISCOS E BENEFÍCIOS	38
6	RESULTADOS	39
6.1	EXPERIÊNCIAS DAS PARTICIPANTES NO IT	41
6.1.1	A perda gestacional como evento naturalizado.....	41
6.1.2	IT fragmentados e ausência de cuidado longitudinal	43
6.1.3	Barreiras de acesso ao diagnóstico de trombofilia.....	43
6.1.4	O acesso ao anticoagulante de alto custo	44
6.1.5	Especificidades do território de fronteira no IT	47
6.2	SÍNTESE DO IT: CONSTRUÇÃO DO MAPA FALADO	49

6.2.1	O IT real: fragmentação, atrasos e responsabilização da mulher.....	50
6.2.2	O IT ideal: coordenação, integralidade e cuidado oportuno	52
6.2.3	O mapa falado como síntese crítica do cuidado em saúde	52
7	DISCUSSÃO	54
7.1	CATEGORIA 1 – A PERDA GESTACIONAL COMO EVENTO NATURALIZADO	54
7.2	CATEGORIA 2 – OS ITS FRAGMENTADOS	55
7.3	CATEGORIA 3 – AS BARREIRAS DE ACESSO AO DIAGNÓSTICO	56
7.4	CATEGORIA 4 – O ACESSO AO ANTICOAGULANTE DE ALTO CUSTO	57
7.5	CATEGORIA 5 – AS ESPECIFICIDADES DO TERRITÓRIO DE FRONTEIRA	59
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	60
	REFERÊNCIAS	62
	APENDICE I – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA	70
	APENDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)	71
	ANEXO I – TERMO DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)	73

1 INTRODUÇÃO

A trombofilia é uma condição caracterizada por uma predisposição para a formação de coágulos sanguíneos e, durante a fase gestacional, ocorrem alterações fisiológicas nos fatores de coagulação sanguínea o que pode levar a formação de trombos. Para uma gestante trombofílica os riscos podem ser aumentados para o desenvolvimento de complicações, tais como abortos recorrentes, restrição de crescimento fetal, pré-eclâmpsia, óbito intrauterino, Tromboembolismo Venoso (TEV), e outras condições que afetam tanto a mãe quanto o bebê, requerendo uma atenção especial durante o acompanhamento gestacional (Febrasgo, 2020).

As trombofilias são classificadas em: *i*) trombofilias hereditárias, quando há uma predisposição genética à formação de coágulos por erros no sistema de proteínas que inibem a coagulação e *ii*) trombofilias adquiridas, relacionadas a fatores clínicos como imobilização, cirurgias, presença de anticorpos antifosfolípidos e uso de alguns medicamentos (Dicks *et al.*, 2024).

O diagnóstico precoce e o gerenciamento adequado da trombofilia durante a gravidez, devido ao estado de pró-coagulação, são essenciais para garantir um acompanhamento seguro e bem-sucedido da mãe e o filho (Tsikouras *et al.*, 2020). O tratamento adequado e a prevenção são ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e são dois os fármacos anticoagulantes de primeira escolha: enoxaparina sódica e Ácido Acetilsalicílico (AAS).

O Ministério da Saúde (MS), em conjunto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, por meio da Portaria conjunta nº 23, de 21 de dezembro de 2021, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia no âmbito do SUS. Este documento define uma sequência de padrões clínicos e laboratoriais para o diagnóstico de trombofilia gestacional, a fim de qualificar o recebimento do tratamento com a enoxaparina sódica, que é um medicamento de alto custo (Brasil, 2021).

A trombofilia tende a ser clinicamente assintomática e frequentemente descoberta pela mulher de forma ocasional durante gestação ou após um evento obstétrico negativo, uma vez que a gravidez é um estado de hipercoagulabilidade, em que as funções fisiológicas se adaptam para minimizar o risco de hemorragias no parto. No entanto, quando associada a uma predisposição trombogênica pré-existente, como na trombofilia, esse estado aumenta significativamente o risco de complicações tromboembólicas, tanto maternas quanto fetais, tornando o diagnóstico e manejo dessa condição essencial para a prevenção de desfechos

adversos na gestação e no puerpério (Wawrusiewicz-Kurylonek *et al.*, 2020).

Estudos mostram que os riscos maternos no pós-parto são de 15 a 35 vezes maiores do que em outros períodos gestacionais. Os riscos à saúde materna surgem já no primeiro trimestre, que se intensificam ao longo da gestação e podem se agravar no puerpério (Brasil, 2022; Kalaitzopoulos *et al.*, 2022). Quando a Trombose Venosa Profunda (TVP) não identificada e tratada na gravidez, ela se torna um fator agravante para o desencadeamento de uma Embolia Pulmonar (EP), o que pode ser prejudicial para a mãe e o recém-nascido (McLean; Cushman, 2016).

Outra pesquisa realizada em 2018 pelo MS, apontou cerca de 2.459 mortes de mulheres no período gestacional ou puerpério por diagnósticos variados, incluindo casos que se assemelham aos de trombofilia. A identificação precoce e o manejo adequado das trombofilias poderiam contribuir para a redução desses índices alarmantes (Brasil, 2018).

Mulheres que possuem histórico de uma ou mais perdas gestacionais e/ou outras complicações na gestação, frequentemente não são incluídas no protocolo por não atenderem aos critérios clínicos, o que dificulta tanto o acesso ao tratamento quanto a obtenção de um diagnóstico conclusivo de trombofilia. Assim, a investigação da trombofilia deveria ocorrer não apenas nos momentos previstos pelo protocolo, mas de forma profilática, em etapas anteriores, como na prescrição de anticoncepcionais, na decisão sobre a reprodução familiar e na reposição hormonal.

Diante desse cenário, emerge a necessidade de compreender como as gestantes vivenciam o percurso assistencial diante das exigências do protocolo clínico e das especificidades do contexto fronteiriço. Considerando as limitações impostas pelos critérios do PCDT para a trombofilia gestacional, especialmente em contextos marcados por vulnerabilidades sociais e territoriais, como os municípios de fronteira, torna-se necessário compreender como as gestantes vivenciam o acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

Assim, a presente pesquisa é orientada pela seguinte questão norteadora: Como se estrutura o Itinerário Terapêutico das gestantes que demandam o uso de anticoagulante em um município de fronteira, e quais são as particularidades e repercussões do protocolo clínico na segurança gestacional e no bem-estar materno e fetal?

2 JUSTIFICATIVA

A interrupção da gravidez é angustiante para os casais que desejam ter filhos e a perda gestacional causa intensa dor e sofrimento à mulher que estava grávida, em virtude da idealização que fez de seu filho. O aborto pode desencadear conflitos para a mulher que estava gestando e na sua família, resultando em uma situação de desamparo diante da perda (Da Rosa, 2020).

Estudos recentes indicam que a Síndrome HELLP (hemólise, enzimas hepáticas elevadas e contagem baixa de plaquetas) pode aumentar o risco de mortalidade materna em até 10 vezes. Quando associada ao estado de pré-eclâmpsia, essas condições tornam-se as principais causas de mortalidade materna e perinatal, acometendo uma extensa morbidade. Ambas estão relacionadas a complicações tromboembólicas, venosas ou arteriais, sendo critérios clínicos importantes no diagnóstico de trombofilias gestacionais, salientando a necessidade de acompanhamento rigoroso e intervenções precoces para minimizar os riscos gestacionais (Coral-Almeida *et al.*, 2024).

Apesar dos riscos gestacionais, a investigação e rastreamento de trombofilias para todas as gestantes não está indicada pelo MS, e sequer é recomendada como prática rotineira durante o pré-natal. Ainda que o MS tenha elaborado o PCDT, que estabelece os critérios para diagnóstico e tratamento de trombofilias gestacionais, o diagnóstico correto nem sempre acontece e os critérios de inclusão para que a gestante receba o tratamento com Enoxaparina sódica são muito restritivos à presença da Síndrome Antifosfolípide (SAF) e história pregressa de TEV (Brasil, 2021).

A área de fronteira do Brasil é dividida com 10 países sul-americanos. Neste amplo território são 588 municípios em 11 estados, deste total, 139 estão concentrados no estado do Paraná. Foz do Iguaçu faz parte de uma fronteira trinacional (Brasil, Paraguai e Argentina) e municípios fronteiriços são demarcados por um limite territorial de 150 quilômetros paralelos à linha de divisória entre o Brasil e outros países (Brasil, 1979).

Regiões de fronteiras são complexas e vão além da esfera jurídica e formal, necessitam ser compreendidos por políticas e programas de saúde pública, pela razão da livre circulação concomitando elementos de integração e de desordens que precisam ser acatados na determinação social do processo saúde-doença para seu enfrentamento (Haum; Carvalho, 2021).

A tríplice fronteira de Foz do Iguaçu é caracterizada por um fluxo contínuo comercial e

turístico coexistindo um território multicultural e internacional. A transfronteirização é um método social que estimula os residentes fronteiriços a cruzarem a fronteira em busca de recursos de vida como, trabalho, educação, e sobretudo assistência à saúde (Aikes; Rizzotto, 2018).

Devido aos princípios de integralidade e universalidade de acesso ao SUS, habitantes dos países vizinhos procuram os serviços de saúde no Brasil. Neste caso, Foz do Iguaçu é a cidade de busca por melhores condições de atendimento e atenção à saúde, majoritariamente pelos paraguaios e brasileiros residentes no Paraguai, principalmente para assistência de serviços ligados à atenção materno infantil. Gestantes paraguaias ou brasileiras que moram no Paraguai (em *Ciudad del Este*) recorrem ao serviço brasileiro para o parto de seus filhos, e estes, de nacionalidade brasileira, têm o direito de amparo oferecido pelo SUS (Picco *et al.*, 2022).

A vulnerabilidade das gestantes imigrantes pode ser compreendida em três dimensões: individual, social e programática. A dimensão individual refere-se à suscetibilidade biológica e à falta de acesso à informação, enquanto a social abrange aspectos como pobreza e exclusão, dificultando o acesso a cuidados adequados. A dimensão programática diz respeito às limitações estruturais e institucionais nos serviços de saúde. Para garantir um atendimento eficaz, é fundamental que políticas públicas e profissionais integrem essas dimensões, considerando o contexto cultural e social dessas mulheres, promovendo um cuidado mais acessível e equitativo (Zarth *et al.*, 2024)

No Brasil, é comum e desordenado o uso indevido de comprovantes de residência por parte de estrangeiros, os quais, utilizando documentos que não correspondem à sua moradia fixa, buscam obter o Cartão Nacional de Saúde (CNS), também conhecido como Cartão SUS, com o objetivo de acessar o sistema de saúde brasileiro. Tal prática configura-se como uma problemática pública, uma vez que dificulta o registro adequado da quantidade de atendimentos prestados tanto a estrangeiros quanto a brasileiros não residentes, comprometendo a gestão e o controle do sistema de saúde (Hirano *et al.*, 2023).

Essa população denominada flutuante não é contabilizada a termos de repasses financeiros, justamente por não serem registrados corretamente ao sistema organizacional. Diante desta demanda, o Governo Federal implantou em 2006 o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (Sis-Fronteiras), com o objetivo de melhorar o orçamento e oferta de serviços de saúde para os brasileiros que moram no exterior (Mello; Victora; Gonçalves, 2015).

O Programa Sis-Fronteira foi uma importante política pública específica para os municípios de fronteiras trazendo um debate sobre questões pontuais e características dessas

regiões no âmbito da saúde (Haum; Carvalho, 2021). Com verbas provenientes do Sis-Fronteira, o Centro Materno Infantil (CMI) foi construído em 2007 para prestar atendimento as gestantes brasileiras que residem no exterior, sendo o único no Brasil a realizar esse tipo de serviço. Pois, antes dele as mulheres grávidas procuravam o hospital do município somente no momento do parto, o que não poderia ser negado, desde então com a criação do CMI elas tem a oportunidade do livre acompanhamento no pré-natal (Mello; Victora; Gonçalves, 2015).

Infelizmente o SIS-Fronteiras foi desativado de forma gradativa em 2012 e encerrada por completo em 2014, por meio da Portaria nº 622/2014, o que deixou a população e os governos locais com poucos recursos ou desamparados financeiramente para continuar prestando este atendimento (Brasil, 2014). Destarte, em 29 de maio de 2024 o Diário Oficial da União (DOU) nº 12.038, institui a Política Nacional de Fronteiras (PNF) e seu Comitê Internacional, tornando-se a primeira PNF que prevê ser multissetorial para dialogar com os setores da educação, saúde e economia (Brasil, 2024).

Considerando o cenário fronteiriço e que a ocorrência de trombofilias gestacionais, ou de casos que se assemelham a elas, é frequentemente negligenciada devido à escassez de publicações sobre o tema. Conhecer o IT dessas mulheres, especialmente no que diz respeito a esse subgrupo de mulheres que necessitam de medicação de alto custo, fornecida pela 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, PR, torna-se imperativo para a formulação de políticas públicas que visem reduzir a incidência de perdas gestacionais associadas à trombofilia.

Avaliando essa realidade, surge a necessidade de conduzir um estudo sobre o IT de gestantes que não se enquadram nos critérios do PCDT, uma vez que elas enfrentam dificuldades para obter um diagnóstico conclusivo e receber o tratamento com Enoxaparina sódica.

A autora, biomédica de formação, possui um histórico pessoal que converge para a presente investigação. Sua trajetória foi marcada por uma perda gestacional tardia ocorrida às 38 semanas de gestação, em 2015, e pela subsequente busca por diagnóstico. Durante essa fase, identificou uma lacuna significativa na disponibilização de informações e no suporte prestado às mulheres que vivenciam essa situação. No decorrer desse percurso, foi diagnosticada com trombofilia e, ao engravidar novamente em 2018, enfrentou desafios substanciais para obter a enoxaparina pelo sistema público de saúde. A obtenção do medicamento de alto custo, essencial para a continuidade segura da gestação, ocorreu apenas no oitavo mês gestacional, após a judicialização do processo. Durante esse período, a autora teve que arcar com os custos do tratamento, dada a espera da liberação pela 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu.

A motivação para o presente estudo emerge, portanto, dessa vivência pessoal aliada à percepção de que essa problemática se estende a outras mulheres, muitas das quais a buscaram para obter informações sobre exames, médicos especialistas, diagnósticos e os trâmites necessários para conseguirem a medicação pelo Estado do Paraná. Ademais, sua participação em grupos de apoio a mulheres que enfrentaram perdas gestacionais reforçou a compreensão sobre a necessidade de fortalecer políticas públicas e melhorar o acesso ao tratamento adequado, especialmente em regiões de fronteira, onde as dificuldades logísticas e administrativas podem agravar a vulnerabilidade das gestantes com condições clínicas específicas, como a trombofilia.

A presente pesquisa insere-se na linha de investigação de Epidemiologia e Vigilância em Saúde de Fronteira ao abordar as barreiras no acesso ao diagnóstico e tratamento da trombofilia em gestantes ou a quadros clínicos semelhantes. Ao investigar os desafios enfrentados por essas mulheres no contexto do SUS, busca-se não apenas contribuir para o aprimoramento das políticas de assistência materno-infantil, mas também fornecer subsídios para a formulação de estratégias que garantam um atendimento equitativo e resolutivo. Embora a construção do PCDT em 2021 tenha estabelecido critérios clínicos e laboratoriais para o manejo da trombofilia na gestação, ainda há limitações na inclusão de todas as gestantes que necessitam de tratamento com enoxaparina sódica.

3 OBJETIVO

Descrever o itinerário terapêutico de gestantes que demandam tratamento com anticoagulante em um município de fronteira internacional.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever o perfil sociodemográfico e obstétrico das participantes.

Investigar os fatores socioeconômicos e culturais que influenciam o acesso ao tratamento com anticoagulante por gestantes na região de fronteira.

Identificar os principais desafios enfrentados por essas gestantes no acesso ao tratamento adequado.

Investigar como se estrutura o itinerário percorrido pelas gestantes que necessitam de terapia anticoagulante em um município de fronteira.

Analisar a partir da percepção das gestantes sobre a qualidade do atendimento e o acompanhamento médico durante o tratamento com anticoagulante.

4 QUADRO TEÓRICO

4.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa o primeiro nível de cuidado e engloba uma série de ações voltadas para a saúde tanto a nível individual quanto coletivo. Isso inclui promoção e preservação da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, proporcionando um cuidado completo que tenha um impacto positivo na saúde das comunidades (Martins *et al.*, 2022).

Para garantir sua efetividade nos sistemas de saúde, a APS é estruturada a partir de atributos essenciais, conforme descrito por Starfield (2002). Entre eles, destacam-se o acesso como ponto de primeiro contato, assegurando a APS como porta de entrada preferencial; a longitudinalidade, que favorece o vínculo contínuo entre profissionais e pacientes; a integralidade, permitindo uma abordagem abrangente das necessidades de saúde; e a coordenação do cuidado, promovendo a articulação entre os diferentes níveis de atenção. Além disso, os atributos derivados (orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural) reforçam a capacidade da APS de responder às necessidades individuais e coletivas, promovendo equidade e eficiência nos sistemas de saúde (Starfield, 2002).

Esta é a principal porta de entrada para o SUS e o ponto de ligação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS. Deve-se guiar pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, responsabilidade, humanização e equidade. Isso quer dizer que organiza o encaminhamento dos serviços na rede de saúde, desde os mais simples até os mais complexos (Brasil, 2023).

A equipe de Atenção básica na APS é composta por um profissional médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. A equipe de saúde bucal e os agentes de combates às endemias também podem fazer parte do quadro de funcionários (Veloso *et al.*, 2024). Conforme ressalta Biage *et al.*, (2018) o enfermeiro tem qualificação e autonomia para conduzir a assistência ao pré-natal e atuar na promoção da saúde e na prevenção de doenças e seus agravos. Isto reflete na redução de complicações e diminuição das taxas de mortalidade materna e infantil.

A tomada de decisões assertivas e a estratificação de risco são fundamentais para garantir uma gestação segura, principalmente quando se trata de um pré-natal de alto risco, onde os enfermeiros, realizam ações voltadas à prevenção e ao tratamento de morbidades

contribuindo para o bem-estar da gestante e do bebê (Jorge *et al.*, 2020).

Durante a realização do trabalho ativo, é possível realizar uma avaliação dos usuários com critérios de diagnósticos, para identificar as necessidades e demandas assistenciais, reconhecer populações mais susceptíveis ao cuidado fragmentado, e apontar os prováveis desafios da gestão do cuidado (Araújo *et al.*, 2023).

O futuro dos sistemas de saúde baseia-se em envolver a integração em RAS, funcionando de maneira mais cooperativa e compartilhada, a fim de eliminar redundâncias como também a implementação de diretrizes clínicas, integração vertical e horizontal dos serviços, e um foco constante para a qualidade (Nakata *et al.*, 2020).

Um mecanismo importante para avaliação da complexidade da APS com a RAS é a implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde (TICS), sendo capaz de trazer uma mudança no processo de trabalho, possibilitando de forma eficaz acessar ao usuário, facilitar o processo de ensino-aprendizagem, e permitindo que sejam construídas em conjunto, as tomadas de decisões clínicas (Bender *et al.*, 2024a). Desde a iniciativa do Governo Federal em 2011, várias melhorias foram alcançadas, porém ainda há carência de equipamentos e acesso de internet de qualidade na APS, limitando a aplicabilidade do recurso (Bender *et al.*, 2024b).

4.2 SAÚDE DA MULHER

As políticas públicas que envolvem a saúde da mulher vêm mudando ao longo dos anos, desde o início da década de 80, quando o teor era voltado para questões relativas à gestação e à atenção ao recém-nascido de forma verticalizada e isolada, sem integração com outros temas de saúde. Este período foi marcado por políticas com abordagens limitadas e segmentadas nas políticas públicas de saúde para mulheres (Rosa; Cabral, 2023).

No ano de 2004, foi criada a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que teve origem no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), criado em 1983. O PNAISM segue os princípios do SUS de integralidade, universalidade de acesso e equidade do Sistema de serviço. Com inclusão de questões dos direitos sexuais e reprodutivos, combate à violência doméstica e sexual, tratamento do Vírus da Imunodeficiência Humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS) e doenças crônicas não transmissíveis, além dos assuntos em relação a maternidade e prevenção do câncer (Brasil, 2004; Machado; Penna, 2022).

Em 2011, foi instituída a Rede Cegonha (RC), por meio da Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que traz orientações de uma rede de cuidados voltadas ao pré-natal, parto e puerpério, sob o olhar da humanização da assistência à saúde da mulher e da criança até os dois anos de idade. Juntamente com a PNAISM configuram como políticas de Estado, sendo as principais iniciativas do governo em relação à saúde da mulher (Aparecida *et al.*, 2021).

Com intuito de substituir a RC foi instituído em abril de 2022 pela Portaria GM/MS nº 715 A Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil (RAMI) (Brasil.2022), reorganizando o modelo de atenção materno-infantil e centrando-o em um enfoque hospitalar e médico (Mortelaro *et al.*, 2024). A RAMI foi criticada por especialistas, pois a nova abordagem é vista como um retrocesso, pois desvia da integralidade do atendimento e do cuidado humanizado promovido pela RC. Em janeiro de 2023 a Portaria GM/MS nº 13 revoga a RAMI e também reinstalou a RC (Brasil, 2023), marcando o retorno de uma política mais conectada às necessidades da saúde pública e direitos humanos (Gonzalez, 2022).

O conceito de planejamento familiar surge um conjunto de ações destinadas a regular a fecundidade familiar, de modo a garantir direitos iguais, restringindo ou não o número de filhos, seja pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Este termo é mais bem estabelecido quando substituímos por “planejamento reprodutivo”, que engloba a constituir uma família independente dos relacionamentos conjugais estáveis, vida sexual sem parceiros até para os que iniciam a vida sexual (Sousa *et al.*, 2024).

Desta forma, a APS no SUS, desempenha um importante papel no âmbito de atendimento, na promoção da saúde e qualidade de vida da mulher, devendo este atendimento ser individual e específico, para que consiga oferecer a prevenção, o diagnóstico e tratamento das condições que afetam diretamente a saúde feminina. Um dos principais pilares é o acompanhamento do pré-natal e estende-se para a saúde materno-infantil. Assim, muitas vezes o primeiro contato com a assistência em saúde ocorre no pré-natal e é somente neste momento que a gestante busca o atendimento, seja por receios, dúvidas, preocupações ou simplesmente para confirmar uma possível gravidez (Brito *et al.*, 2022).

Nesse sentido, é de fundamental importância estudar e orientar mulheres em idade reprodutiva, uma vez que são jovens e passíveis à prevenção de doenças, prevenção de gestação precoce e, principalmente, de complicações na gestação. A assistência deve englobar todo o ciclo vital em suas distintas fases. Torna-se assim um desafio para os profissionais da saúde aproveitarem as oportunidades em que as mulheres procuram ou estão na APS e orientá-las por cuidados essenciais e assim conseguir implementá-los de modo abrangente (Mendes, 2016).

4.3 TROMBOFILIAS

O período gestacional é uma fase muito importante da vida da mulher e da família, momento que requer atenção e cuidados prioritários. Segundo Hu e Zhang (2021), o sucesso de uma gravidez é dado pela saúde materna, que está intimamente relacionada ao sistema vascular do útero e da placenta. É por meio do estabelecimento desse sistema vascular uteroplacentário que se inicia a interação do endotélio vascular materno.

É um período para adotar medidas de precaução, pois a gestante pode apresentar fatores de risco e quanto mais precoces forem identificados, melhor, porque permitirá tratamentos e cuidados perinatais necessários (Holt *et al.*, 2024).

A trombofilia é um dos fatores de risco para gestantes devido à propensão a desenvolver eventos tromboembólicos, que se tornam mais acentuados durante a gravidez devido às características pró-coagulantes desse período. Isso ocorre em virtude do aumento dos níveis hormonais, da redução do fluxo venoso nos membros inferiores, de fatores mecânicos como a pressão adicional nos vasos pélvicos devido à compressão uterina, e de alterações hemostáticas que podem levar a erros no sistema de coagulação, predispondo à formação de coágulos no sistema circulatório (Ridder, *et al.*, 2019).

As gestantes apresentam os três componentes principais da tríade de Virchow, que são fatores essenciais para o desenvolvimento de trombose. O primeiro componente, a estase venosa, devido a compressão de veias pelo crescimento do útero, o segundo componente, é a hipercoagulabilidade e o terceiro a lesão endotelial, contribuindo assim para ativação do sistema de coagulação (Wang *et al.*, 2023; Oliveira; Marques, 2016).

O TEV é a manifestação mais comum da trombofilia e representa uma das principais causas de morbimortalidade materna, podendo resultar em complicações como Trombose Venosa Profunda (TVP) e Tromboembolismo Pulmonar (TEP) (Baptista; Oliveira, 2008). Ressaltando que a mulher grávida está 4 a 5 vezes mais propensa a desenvolver TEV do que as não grávidas (Middeldorp; Naue; Köhler, 2022).

Neste contexto, as trombofilias são divididas em duas categorias: as hereditárias e as adquiridas. As hereditárias estão relacionadas à deficiência de proteínas que inibem a coagulação, tais como antitrombina, proteína C e proteína S, além das mutações do fator V de Leiden e a mutação *G20210A* no gene da protrombina (Brasil, 2021).

E há uma outra divisão considerando as hereditárias de alto risco a presença de mutação homozigótica para o fator V de Leiden, mutação homozigótica para o gene da protrombina,

deficiência da antitrombina III, associação de mutações heterozigóticas para o fator V de Leiden e do gene da protrombina, também a presença de SAF. As de baixo risco incluem a mutação heterozigótica para o fator V de Leiden, mutação heterozigótica para o gene da protrombina, deficiência da proteína C ou da proteína S. Por outro lado, as trombofilias adquiridas surgem devido à presença de anticorpos antifosfolípidos, conhecida como SAF, principalmente os anticorpos anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e o anticorpo anti- β 2-glicoproteína I (Tao *et al.*, 2023).

4.4 PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT)

O PCDT estabelece uma série de critérios clínicos e laboratoriais para o diagnóstico de trombofilia gestacional à caráter de ter o direito de receber o tratamento com enoxaparina sódica por se tratar de um medicamento de alto custo. A portaria preconiza ainda que não é recomendado a realização de investigação laboratorial de trombofilias para todas as gestantes.

A avaliação laboratorial deve ser realizada em situações específicas, tais como: mulheres com histórico pessoal de TEV, independentemente da presença ou ausência de fatores de risco recorrentes, e desde que não tenham realizado teste de trombofilia previamente; mulheres com histórico familiar de trombofilia hereditária em parentes de primeiro grau (neste caso, investigar somente trombofilias hereditárias); ou mulheres com histórico clínico que corresponda à SAF, de acordo com os critérios clínicos que incluem um ou mais episódios de trombose venosa ou arterial documentados por exame de imagem ou evidência histológica sem sinal de vasculite; histórico de pelo menos três abortos precoces (com menos de 10 semanas) sem causa aparente; histórico de óbito fetal após as dez semanas com feto morfologicamente normal e sem causa aparente; ou histórico de parto prematuro antes das 34 semanas de gestação com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia ou insuficiência placentária; e diagnóstico de SAF (Brasil, 2021).

As consequências obstétricas de uma trombofilia não diagnosticada e não tratada vão desde aborto de repetição, restrição de crescimento fetal, parto prematuro, pré-eclâmpsia, disfunção placentária a óbito fetal intrauterino. Para a mãe, o risco aumenta ainda mais no período pós-parto no qual os eventos de TEV são os mais característicos (Voicu *et al.*, 2020).

4.4.1 Tratamento Profilático

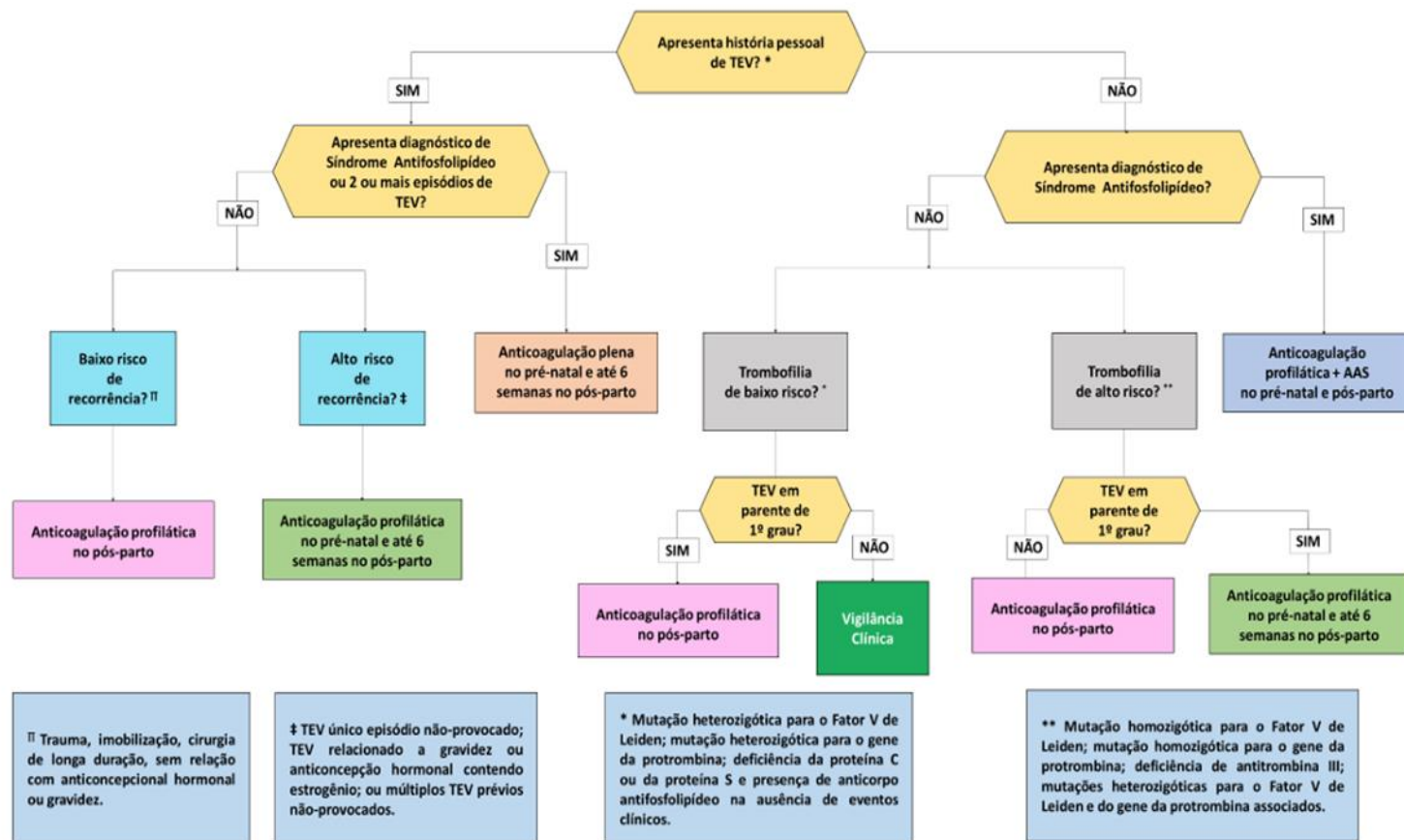
O tratamento e a profilaxia são contemplados pelo SUS com a anticoagulação, Enoxaparina sódica (solução injetável de 40 mg/0,4 mL e de 60 mg/0,6 mL) e AAS (comprimidos de 100 miligramas).

A Enoxaparina sódica é uma heparina de baixo peso molecular caracterizada por apresentar atividade antitrombótica reduzida, agindo através da inibição do fator Xa, com propriedades anti-inflamatórias, contribuindo ainda mais para o seu efeito anticoagulante (Brasil, 2018; Fareed *et al.*, 2003). Entre as vantagens associadas a este medicamento, é importante mencionar que ele não atravessa a barreira placentária, possui um esquema simples posológico de administração e garante um menor risco de eventuais sangramentos (Brasil, 2018).

O AAS inibe a agregação plaquetária, sendo muito utilizado também para outros problemas do sistema vascular. É administrado por via oral e é rapidamente absorvido pelo intestino (tempo de meia-vida de 2 a 3 horas para doses baixas e de 15 horas para altas) sendo convertido em ácido salicílico, seu principal metabólito ativo. Esse fármaco atravessa a placenta e também passa para o leite materno, sendo recomendado suspender o uso por volta das 36 semanas de gestação (Brasil, 2021).

O fluxograma (Figura 1) evidencia os diferentes níveis de risco de recorrência e orienta a indicação de anticoagulação profilática ou plena, tanto no período pré-natal quanto no pós-parto, além da associação com ácido acetilsalicílico em situações específicas. Dessa forma, a Enoxaparina sódica e o AAS, disponibilizados pelo SUS, configuram-se como pilares terapêuticos na profilaxia, alinhando-se às recomendações clínicas para redução do risco tromboembólico materno durante a gestação e o puerpério.

Figura 1 – Fluxograma da prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia



Fonte: Brasil (2021)

4.5 BARREIRAS E DESAFIOS DO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE GESTANTES EM BUSCA DE DIAGNÓSTICO PARA TROMBOFILIA

O Itinerário Terapêutico (IT) pode ser apresentado como um processo de busca de cuidados com a saúde, ponderando tanto as necessidades individuais quanto aos fatores socioculturais que interfiram por essa procura (Demétrio; Santana; Pereira-Santos, 2019). Originalmente o termo começou ser explorado na literatura socioantropológica como "*illness behaviour*" (comportamento do enfermo), um conceito introduzido em 1961, que refletia a escolha do tratamento baseada na lógica de consumo (Mechanic; Volkart, 1960), essa teoria evoluiu com contribuições de Kleinman e seu modelo de Sistemas de Atenção à Saúde (Cabral *et al.*, 2011).

As trajetórias de cuidado são moldadas pelas necessidades, concepções e determinantes sociais das famílias, independentemente de protocolos estabelecidos (Silva; Sancho; Figueiredo, 2016). O IT abrange não apenas o planejamento de ações para enfrentar a doença e promover a saúde, mas também procura explicações significativas socialmente e tratamentos psicossociais para alcançar o bem-estar e/ou a cura (Luz *et al.*, 2019). O vínculo com os serviços de saúde e profissionais pode facilitar essa construção, promovendo a participação familiar e aumentando a eficácia do cuidado (Lima; Toso, 2019).

O IT de gestantes em busca do diagnóstico de trombofilia é um processo longo, complexo e frequentemente desafiador, pois a busca pelo diagnóstico normalmente se inicia após o primeiro aborto espontâneo. Sem orientação assertiva e acesso aos exames laboratoriais, essas mulheres enfrentam perdas gestacionais de repetição, resultando em intervenções invasivas, como a raspagem do colo do útero. A trombofilia, uma condição que aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos, pode ser um fator subjacente significativo em abortos espontâneos recorrentes (Ferreira *et al.*, 2017). A identificação e o tratamento adequados desse quadro são decisivos para melhorar as chances de uma gestação bem-sucedida.

Para confirmar um diagnóstico de trombofilia, é necessário realizar uma série de exames laboratoriais específicos, incluindo testes genéticos relacionados aos fatores de coagulação e análises para identificar níveis anormais de proteínas anticoagulantes (Nascimento *et al.*, 2019). Contudo, gestantes na 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu enfrentam dificuldades no acesso a esses exames para a comprovação do diagnóstico o que leva para uma negativa da solicitação para o recebimento do medicamento de alto custo.

Notoriamente essas mulheres apresentam condições clínicas que se assemelham a

quadros de trombofilias caracterizadas pelo aborto de repetição conforme Ferreira *et al.*, (2017) constatou através do estudo retrospectivo com base em dados coletados de prontuários de 54 mulheres grávidas com marcadores séricos de trombofilia hereditária submetidos à intervenção terapêutica com enoxaparina. Tais dificuldades englobam a falta de recursos para exames laboratoriais e a necessidade de encaminhamento para profissionais especializados na área, resultando em longos períodos de espera. Cada dia de espera representa um risco adicional para a saúde materna e fetal, tornando essa espera uma fonte significativa de preocupação.

Para serem contempladas com o tratamento, as gestantes devem apresentar provas laboratoriais específicas que confirmem a trombofilia de acordo com os critérios estabelecidos no PCDT do Estado, encaminhamento médico com o laudo, exames de imagem quando for caso necessário (Brasil, 2021). A disponibilidade e distribuição de medicamentos de alto custo são regulados pela 9ª Regional de Foz do Iguaçu, e a ausência de um diagnóstico conclusivo impede que muitas gestantes recebam a medicação necessária a tempo de prevenir novas perdas gestacionais.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

A análise do IT foi realizada por meio da técnica de Análise de Conteúdo (AC), adotada com o objetivo de aprofundar a compreensão dos achados empíricos. Seguindo a abordagem de Minayo (2004), a análise de conteúdo é delineada como um conjunto de técnicas que se destina à análise de informações relacionadas ao comportamento humano, oferecendo uma aplicabilidade bastante diversificada. Essa técnica possui duas funções principais: a verificação de hipóteses e/ou questões e a descoberta do que está subjacente aos conteúdos manifestos.

O estudo foi conduzido em conformidade com os *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research* (COREQ), visando assegurar transparência e rigor metodológico na condução e apresentação dos resultados

5.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo caracterizou-se como de natureza qualitativa, exploratória e descritiva. A opção pela abordagem qualitativa justificou-se por sua adequação aos objetivos propostos, fundamentando-se no referencial teórico-metodológico da hermenêutica-dialética. Minayo (2010), compreende o método qualitativo como um modo de conhecer a história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, feito por uma interpretação humana sobre como vivem. Esse método permite revelar processos sociais ainda pouco conhecidos em relação a grupos específicos, possibilitando novas abordagens, como uma revisão de caminho e construção de novos conceitos durante a investigação.

A perspectiva dialética, com seu artifício de separar conduz o conhecimento através da comunicação mútua e abre margem para diversas possibilidades de resposta (Gadamer, 2015). Como este exercício dialético também disserta sobre o fundamento das relações sociais entre classes, grupos e culturas, a abordagem qualitativa da presente investigação requer do pesquisador uma escuta ativa e sensível à pluralidade das vozes das mulheres para compreender o IT na busca de obtenção de medicamentos de alto custo (Soratto *et al.*, 2014; Santos *et al.*, 2019).

O IT foi delineado a partir das entrevistas realizadas com as participantes, com o objetivo de descrever o percurso das gestantes que demandaram tratamento com anticoagulante em um município de fronteira internacional, compreendendo desde a vivência da perda gestacional, as orientações médicas recebidas para investigação diagnóstica (ou a ausência

delas) até o acesso à enoxaparina sódica.

5.2 LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada no município de Foz do Iguaçu, localizado na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, área caracterizada por intensa circulação populacional, presença de população flutuante e desafios históricos relacionados ao financiamento e à organização dos serviços de saúde. O município integra a 9ª Regional de Saúde do Paraná, responsável pela dispensação de medicamentos de alto custo, entre eles a enoxaparina sódica, utilizada por gestantes com indicação de anticoagulação.

Regiões de Saúde são formadas por cidades fronteiriças que partilham aspectos culturais, econômicos e sociais, meio de comunicação e infraestrutura e transportes. Com o objetivo de assegurar o acesso assertivo para a população entre esses territórios vizinhos, dispondo de serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em RAS, garantindo a integralidade do SUS (Brasil, 2023).

As regionais de saúde desempenham uma função central ao fornecer suporte fundamental aos municípios, especialmente nas áreas de vigilância em saúde e assistência farmacêutica. Ademais, essas entidades facilitam a negociação e formalização de acordos entre o nível estadual e os municípios, exercendo um papel significativo na disponibilização de medicamentos de alto custo, particularmente aqueles voltados ao tratamento de doenças crônicas (Fatel *et al.*, 2021).

A 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu abrange os municípios de Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu e Foz do Iguaçu. As diretrizes de funcionamento dessas regiões foram estabelecidas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), através da Resolução 1 de 29 de setembro de 2011, e em conformidade com o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 (Brasil, 2023).

Foz do Iguaçu atua como centro de referência para todas as gestantes do município e de Santa Terezinha de Itaipu, independentemente do risco gestacional. Além disso, é referência para gestação de alto risco para os 9 municípios que integram a nona regional de saúde (Oliveira *et al.*, 2020).

5.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO

Participaram do estudo 20 mulheres, selecionadas por amostragem não probabilística do tipo bola de neve (*snowball sampling*). Essa estratégia foi adotada em razão das dificuldades de acesso direto às usuárias vinculadas à 9ª Regional de Saúde, inicialmente previstas como campo de recrutamento, o que inviabilizou a identificação formal das participantes por meio de bases institucionais.

A amostragem em bola de neve é caracterizada pela identificação inicial de participantes que atendem aos critérios de participação do estudo e que, a partir de suas redes e vínculos comunitários, indicam outras pessoas em condições semelhantes, possibilitando o acesso a populações de difícil localização ou pouco visíveis nos registros oficiais (Biernacki; Waldorf, 1981; Vinuto, 2014). Após o contato inicial com as primeiras participantes, estas passaram a indicar outras mulheres que vivenciaram situações semelhantes relacionadas ao uso de anticoagulante durante a gestação, configurando um processo de recrutamento progressivo, que se baseou na confiança e no reconhecimento entre pares.

Quanto aos critérios de inclusão: gestantes ou puérperas que, passaram por perda gestacional nos últimos 10 anos (2015 a 2025) e fizeram uso de anticoagulante durante a gestação, residentes nas cidades que abrangem a 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu. Como critérios de exclusão indica-se ser menor de 18 anos de idade e possuir outro problema de saúde que impeça a sua participação.

As entrevistas foram conduzidas até o ponto de saturação dos dados, conforme descrito por Minayo (2014). Este conceito refere-se ao momento em que a coleta de novas informações não acrescenta mais dados relevantes ou significativos ao estudo, indicando que o levantamento de dados já é suficiente para compreender o fenômeno em questão. As participantes apresentaram diversidade quanto à idade, escolaridade, condição socioeconômica, histórico obstétrico e vínculo com o sistema público e/ou privado de saúde, o que contribuiu para ampliar a densidade analítica do material empírico.

Para garantir o anonimato, as participantes foram identificadas pela letra “M” (mulher), seguida de numeração sequencial (M1 a M20).

5.4 ENTREVISTA

A produção dos dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas de forma presencial ou remota, conforme disponibilidade e preferência das participantes. Utilizou-se um roteiro previamente elaborado (Apêndice I), contemplando questões relativas ao perfil

sociodemográfico e gestacional, às experiências de perda gestacional, às orientações recebidas nos serviços de saúde, à investigação diagnóstica de trombofilia, ao acesso ao tratamento com anticoagulante e às estratégias adotadas diante das barreiras encontradas.

A entrevista constitui um instrumento primordial para a coleta de dados em pesquisas no campo da saúde, configurando-se como método de construção de conhecimento sobre um fenômeno específico em determinada realidade social (Minayo, 2013). A coleta de dados foi conduzida por biomédica e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira (PPGSPRF).

Antes do início da coleta de dados, foram realizados quatro testes piloto, com o objetivo de avaliar e ajustar o roteiro das entrevistas, assegurando a clareza, a pertinência e a compreensão das perguntas. Os dados provenientes dessas entrevistas piloto não foram incluídos na análise final da pesquisa.

Após os ajustes necessários, procedeu-se ao contato inicial com os potenciais participantes, por meio de mensagens de texto via aplicativo WhatsApp®, para apresentação dos objetivos do estudo e convite à participação. Mediante concordância em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo este apresentado em formato impresso nas entrevistas presenciais e em formato digital nas entrevistas remotas.

As entrevistas remotas e gravação ocorreram por meio da plataforma Google Meet®, sendo previamente agendadas em dia e horário definidos com a participante. As entrevistas presenciais também foram previamente agendadas, ocorrendo na residência da própria participante e mediante o deslocamento da pesquisadora até o domicílio da entrevistada, assegurando-se a realização da entrevista em ambiente reservado e com privacidade.

Todas as entrevistas, tanto presenciais quanto remotas, foram gravadas mediante autorização prévia das participantes, utilizando aplicativo gravador digital, com registro do horário de início e término de cada interação. A duração média das entrevistas foi de aproximadamente 45 minutos.

Posteriormente, os áudios foram transcritos na íntegra no programa Microsoft Word®, possibilitando a organização do material empírico e sua posterior análise por categorias temáticas, conforme proposto por Minayo (2013).

5.5 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados foi realizada por meio da AC, conforme proposta por Bardin (2011),

em diálogo com a abordagem hermenêutico-dialética de Minayo (2004). Inicialmente, procedeu-se à leitura flutuante do material empírico, com o objetivo de apreender o conjunto dos discursos e identificar núcleos de sentido recorrentes.

Na etapa seguinte, realizou-se a codificação do material, considerando as unidades de registro (trechos, frases e expressões significativas) e as unidades de contexto, relacionadas às histórias de vida, aos momentos gestacionais e à interação das participantes com os serviços de saúde. Esse processo possibilitou a identificação de cinco categorias temáticas, utilizados como organizadores da análise:

- (1) a perda gestacional como evento naturalizado;
- (2) os ITs fragmentados;
- (3) as barreiras de acesso ao diagnóstico;
- (4) o acesso ao anticoagulante de alto custo;
- (5) as especificidades do território de fronteira.

A partir da articulação dessas categorias, da interpretação dos discursos e da contextualização social, institucional e política das experiências narradas, emergiram categorias analíticas finais, compreendidas como sínteses interpretativas que expressam não apenas o que foi vivenciado pelas mulheres, mas também os determinantes estruturais que atravessam o cuidado em saúde no contexto estudado.

5.6 ASPECTOS ÉTICOS

Para cumprir com as diretrizes estabelecidas pela CNS 466/2012, que regula a pesquisa envolvendo seres humanos, este estudo somente teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) (Anexo I). Os participantes foram convidadas a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice II), que detalhou a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, possíveis riscos e benefícios, bem como informações sobre ressarcimento e indenização. Além disso, o TCLE destacou a importância da participação voluntária e o direito dos participantes de retirar-se do estudo a qualquer momento, se assim desejassem. A confidencialidade e o anonimato das participantes foram rigorosamente respeitados durante a análise de seus relatos e em todas as fases do desenvolvimento desse estudo.

5.7 RISCOS E BENEFÍCIOS

Os riscos da pesquisa estiveram relacionados aos possíveis desconfortos emocionais e constrangimentos que puderam emergir durante as entrevistas, especialmente ao rememorar e relatar situações vivenciadas ao longo do processo gestacional e das perdas sofridas. Ressalta-se que todas as participantes tiveram assegurado o direito de não responder a quaisquer perguntas e de interromper a entrevista a qualquer momento, sem prejuízo de qualquer natureza.

Em situações de necessidade, foi garantida a possibilidade de encaminhamento para atendimento adequado, de forma imediata, integral e gratuita. Quanto aos riscos relacionados à confidencialidade das informações, foram adotadas medidas de segurança para prevenir perda ou vazamento de dados, com armazenamento dos materiais em pastas de acesso restrito à pesquisadora. As participantes também foram informadas sobre o direito à indenização, na ocorrência de eventuais danos decorrentes da participação na pesquisa, conforme previsto nas normativas éticas vigentes.

Os resultados desta pesquisa não trouxeram benefícios diretos imediatos às participantes, entretanto, sua participação foi fundamental para a compreensão do IT de gestantes que necessitam de anticoagulação, mas que enfrentam dificuldades para acessar o medicamento de alto custo em razão da ausência de diagnóstico conclusivo de trombofilia e/ou do não enquadramento nos critérios clínicos estabelecidos.

A investigação possibilitou a obtenção de informações relevantes sobre o seguimento da saúde de gestantes com histórico de perdas gestacionais e quadros clínicos que se assemelham à trombofilia no âmbito da APS, bem como sobre as orientações recebidas, os encaminhamentos realizados e os fatores que facilitaram ou dificultaram esse percurso. Esses achados contribuem para a reflexão crítica sobre a organização do cuidado, subsidiando ações de Educação Permanente em Saúde, o aprimoramento de fluxos assistenciais e a qualificação dos profissionais envolvidos no acompanhamento de gestações de alto risco.

Nesse sentido, os resultados do estudo apontam potencial contribuição para a redução da morbimortalidade materno-infantil por causas evitáveis, como trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal, perdas gestacionais de repetição, tromboembolismo pulmonar e óbito fetal intrauterino.

6 RESULTADOS

Participaram da pesquisa 20 mulheres, mas uma das participantes foi excluída do estudo por não pertencer à 9ª Regional de saúde de Foz do Iguaçu, o que só foi identificado posteriormente à seleção. Quanto ao perfil, as 19 participantes eram predominantemente adultas, com idades concentradas entre 30 e 40 anos, além de um contingente expressivo com mais de 40 anos (Tabela 1). Trata-se, portanto, de um grupo em idade reprodutiva avançada, com trajetórias pessoais e profissionais já consolidadas.

Tabela 1 – Características sociodemográficas das participantes do estudo (n = 19) sobre o uso de anticoagulantes durante a gestação na 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu, PR, de 2015 a 2025.

Idade	30-40 anos	12	63,2%
	> de 40 anos	7	36,8%
Escolaridade	Até 12 anos de estudo	1	5,3%
	> de 12 anos de estudo	18	94,7%
Cidade pertencente à 9ª Regional de Saúde	Foz do Iguaçu	17	89,5%
	Santa Terezinha de Itaipu	2	10,5%
Possui assistência suplementar	Sim	18	94,7%
	Não	1	5,3%
Profissão / Ocupação	Servidora pública	5	26,3%
	Do lar	1	5,3%
	Profissional da saúde	4	21%
	Diversos / Outros	9	47,4%
Renda	Até 3 salários-mínimos	1	5,3%
	Maior de 3 salários-mínimos	18	94,7%

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Em relação à escolaridade, verificou-se um perfil educacional elevado, uma vez que a quase totalidade das participantes possuía mais de 12 anos de escolaridade, correspondendo, no mínimo, ao ensino superior completo. Apenas uma participante apresentava escolaridade até o ensino médio. Tal nível de instrução pode influenciar a forma como as participantes compreendem e se relacionam com as práticas de saúde, especialmente no acesso e na adesão aos serviços.

Quanto ao local de residência, a maioria das mulheres vivia no município de Foz do Iguaçu, com menor representação de Santa Terezinha de Itaipu, ambos pertencentes à 9ª Regional de Saúde do Paraná. No que se refere ao acesso aos serviços de saúde, predominou a

presença de assistência suplementar, sendo que apenas uma participante dependia exclusivamente do SUS. A presença de cobertura privada sugere um contexto socioeconômico que possibilita a utilização de diferentes portas de entrada no sistema de atenção.

A inserção ocupacional/profissional mostrou-se mais diversificada, com predomínio de participantes economicamente ativas, destacando-se servidoras públicas (5), profissionais da área da saúde como psicologia enfermagem e farmácia (4) e outras ocupações de nível técnico ou superior, dentre as quais existiam assistente social, advogada, contadora, arquiteta, engenheira e profissional autônoma. Dessa forma, o perfil das participantes reflete na sua renda familiar, majoritariamente superior a três salários-mínimos.

Quanto as características obstétricas e gestacionais das participantes, considerando o número de gestações, tipo de parto, ocorrência de perdas gestacionais, procedimentos realizados e complicações obstétricas relatadas. A apresentação desses dados permite delinear o histórico reprodutivo das mulheres e evidenciar a presença de trajetórias marcadas por risco obstétrico e eventos adversos ao longo da gestação (Tabela 2)

Tabela 2 – Características obstétricas e gestacionais das participantes do estudo (n = 19) sobre o uso de anticoagulantes durante a gestação na 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu, PR, de 2015 a 2025.

Nº de gestações	1 a 3	15	78,9%
	3 a 5	3	15,8%
	> que 5	1	5,3
Tipo de parto	Cesáreo	26	
	Normal	6	
Perda gestacional	Sim	11	
	Não	6	
Passou por curetagem	Sim	11	
	Não	6	
Fase da perda gestacional	1º trimestre	23	
	2º trimestre	3	
	3º trimestre	1	
Complicação gestacional	Deslocamento de placenta	2	
	Pré-eclâmpsia no 2º trimestre	1	
	Pré-eclâmpsia no 3º trimestre	5	

Fonte: Dados da pesquisa (2026)

No que se refere à realização de curetagem uterina, observou-se que 11 participantes

relataram ter sido submetidas a esse procedimento ao longo de sua história obstétrica. Entre essas mulheres, a maioria realizou curetagem entre uma e duas vezes ($n = 4$) ou entre duas e três vezes ($n = 5$), enquanto um número menor foi submetido ao procedimento em mais de três ocasiões ($n = 2$). Esses achados evidenciam uma frequência relevante de intervenções uterinas prévias entre as participantes com histórico de perdas gestacionais, refletindo a complexidade do percurso reprodutivo desse grupo e reforçando a importância do acompanhamento clínico individualizado durante a gestação.

Em relação ao perfil gestacional, a maioria das participantes relatou histórico de uma a três gestações, embora o grupo reúna trajetórias gestacionais variadas nas quais enfrentaram repetidas tentativas até a consolidação de uma gravidez bem-sucedida. Observou-se predominância de partos cesáreos (26), distribuição se aproxima do padrão nacional e pode estar associada ao acompanhamento de gestações consideradas de risco, seja por histórico de perdas, seja por complicações clínicas.

A ocorrência de perdas gestacionais esteve presente na maior parte das trajetórias reprodutivas (11), com concentração expressiva no primeiro trimestre de gestação (23). A concentração de perdas precoces sugere que parte dessas mulheres pode ter vivenciado condições clínicas não diagnosticadas. Destaca-se que todas as mulheres que vivenciaram perdas relataram a realização de procedimentos de curetagem, muitas delas de forma repetida.

Entre as complicações gestacionais referidas, sobressaíram episódios de pré-eclâmpsia e descolamento de placenta, reforçando o caráter de alto risco obstétrico do grupo estudado. Os dados da pesquisa reforçam a presença de gestações complexas, com necessidade de acompanhamento contínuo e intervenções médicas.

6.1 EXPERIÊNCIAS DAS PARTICIPANTES NO IT

Os achados foram organizados em eixos temáticos que expressam as experiências, percepções e estratégias adotadas pelas 19 mulheres ao longo de seus IT, desde a vivência da perda gestacional até a busca por diagnóstico e tratamento no contexto dos serviços de saúde.

6.1.1 A perda gestacional como evento naturalizado

As participantes descreveram que, após a perda gestacional, frequentemente não receberam orientações clínicas claras, nem explicações consistentes sobre possíveis causas. Quando questionadas sobre “quais orientações você recebeu depois da perda gestacional e por

qual profissional foi feita”, em muitos relatos, a perda foi comunicada como um evento “comum” e “esperado”, com a orientação de que investigações só ocorreriam após múltiplas perdas, especialmente a partir do critério de “três perdas”. Essa naturalização apareceu tanto na ausência total de orientação quanto na ideia de que seria necessário repetir o evento para justificar investigação.

“O primeiro ginecologista disse que era normal perder e que só poderia investigar após três perdas. Achei absurdo. Então procurei outro médico para investigar e ver possíveis causas” (M11).

“Recebi do meu médico, mas, assim, a orientação foi que aquilo era comum e que o protocolo era, depois da terceira perda, fazer a investigação. E que, se eu quisesse tentar de novo, tinha que esperar três meses. Foi basicamente isso. Enfermeiras ou outros profissionais ninguém falou nada” (M08).

Também houve relatos em que a investigação foi sugerida apenas após a segunda perda ou que não ocorreu orientação ou explicação.

“Quem me orientou foi o meu obstetra e ele me orientou para que a gente investigasse depois dessa segunda perda, para podermos investigar melhor o que aconteceu. Se tinha alguma coisa que a gente conseguisse descobrir. Mas isso após a segunda perda” (M20).

“Nenhuma orientação” (M01).

“Não tive nenhuma orientação” (M13).

Além das orientações, as participantes relataram aspectos relacionados ao manejo assistencial e acolhimento no momento da perda, com experiências de sofrimento intensificado pelo ambiente e pela forma de atendimento. Ao serem questionadas sobre “como você foi tratada pelo médico, hospital e equipe diante da perda gestacional?”, houve menções a permanência em espaços compartilhados com puérperas e parturientes.

“Com falta de acolhimento. O pior foi quando fiz a curetagem (...) fui colocada numa sala com todo mundo que estava ganhando bebê, enquanto eu chorava sozinha. Falta de acolhimento, empatia zero” (M02).

“Foi traumatizante. Descobri que os corações tinham parado e tive que passar pelo procedimento junto com outras mães em trabalho de parto. Fiquei na mesma enfermaria ouvindo bebês chorando. No pós-curetagem fiquei na mesma sala que uma mãe com bebê nos braços. Não houve acolhimento, empatia nem equipe multiprofissional” (M11).

“Três vezes tive que passar pelo processo de curetagem. E foi muito triste. Péssimo. Horrível. Você fica junto com as outras gestantes. Eles não respeitam o seu pesar do momento. Eu fui praticamente (...) na última gestação (...) eu fui praticamente a última

assim da noite (...) eu cheguei às 7 horas da manhã e foram fazer a minha curetagem de noite (...) até que eu fiz um escândalo lá (...) eu pedi para me internarem porque eu queria só ir na hora que fossem fazer a curetagem mesmo (...) e você fica lá vegetando, esperando alguém querer te atender. Fica vendo outras mulheres com seus bebês (...) outras mulheres no trabalho de parto (...) A gente passa por tudo isso” (M16).

6.1.2 IT fragmentados e ausência de cuidado longitudinal

Os relatos indicaram que o IT, após as perdas, ocorreu de maneira fragmentada, com encaminhamentos tardios, mudanças de profissionais e busca por respostas por iniciativa das próprias mulheres. Ao serem questionadas se “algum profissional te encaminhou para um especialista? Em que momento você foi encaminhada ao especialista? (pós-perda, pós gestação ou durante a gestação)?”, em parte dos casos, o acesso a especialistas ocorreu apenas após sucessivas perdas.

“Sim, somente após a terceira perda, quando fui encaminhada para o Dr., médico especialista em gestação de alto risco” (M2).

“Sim, para hematologista (...) após atendimento com a nova médica, com intensão no planejamento de nova gestação. Depois da perda gestacional de 20 semanas” (M02).

“Sim, o ginecologista me encaminhou para o hematologista. Após as perdas gestacionais” (M07).

Destaca-se ainda o grupo que não recebeu encaminhamento formal e organizou o cuidado por conta própria, levando exames e buscando especialistas de forma autônoma ou então desencadeou a busca por múltiplos profissionais fora de um fluxo assistencial definido.

“Durante a terceira gestação, quando fui atrás de entender o que aconteceu na segunda gestação que causou a síndrome HELLP (...) fiz exames por conta e levei ao hematologista” (M13).

“O primeiro médico me encaminhou para reumatologista. O segundo não achou necessário, disse que geralmente esses médicos não são especialistas no processo da gravidez. Depois, por conta própria, procurei nutróloga, nutricionista, psiquiatra e psicólogo. Na segunda perda, após os exames.” (M08).

6.1.3 Barreiras de acesso ao diagnóstico de trombofilia

As participantes relataram que a investigação diagnóstica da trombofilia envolveu múltiplos exames laboratoriais, porém com obstáculos relevantes de acesso, sobretudo no sistema público. Indagadas se “algum profissional te encaminhou para realizar exames de investigação para trombofilia e, se sim, quais exames foram prescritos e quais conseguiu fazer? Por qual motivo não conseguiu fazer?”, verificou-se que, em alguns casos, a investigação ocorreu de forma escalonada, com ampliação do painel diagnóstico apenas após novas perdas.

“Inicialmente, apenas os exames básicos (...) exames mais completos foram feitos somente após a terceira perda, com outro médico” (M02).

De modo recorrente, as falas mostraram que os exames não foram realizados via SUS, exigindo custeio particular e/ou complementação por fora do plano.

“Todos particular. Nenhum pelo SUS (...) todos. Todos foram particulares!” (M01).

“Fiz todos os exames solicitados, foram vários genéticos (...) não houve exames que deixei de fazer. Todos fiz por conta própria, particular. Quase nenhum dos que precisava o plano de saúde cobria” (M03).

“Foram solicitados os exames básicos iniciais de trombofilia. Consegui realizar todos, mas o plano não cobriu, então precisei pagar particular. Consegui realizar todos, mas somente por via particular, já que o plano de saúde não autorizou” (M07).

“Fiz todos que o médico pediu pelo plano, alguns não foram cobertos. Dois exames muito específicos custavam R\$ 2 mil cada, então tive que pagar particular. Os outros eu fiz pelo plano. No final, consegui fazer todos os exames pedidos” (M08).

Em parte das trajetórias, as participantes relataram que não houve prescrição inicial de exames, e a investigação começou por busca autônoma.

“Nenhum foi prescrito. Os exames que eu fiz foram por conta própria, lendo e tentando entender o que tinha acontecido. Fiz exames (...) todos deram normais, o único que deu alteração foi o genético de MTHFR” (M13).

6.1.4 O acesso ao anticoagulante de alto custo

As experiências relativas ao acesso à enoxaparina sódica indicaram um percurso

marcado por informação desigual, burocracia, negativas administrativas e, em alguns casos, judicialização. Questionadas sobre “quem te orientou a solicitar o medicamento na 9ª regional?”, parte das participantes recebeu orientação e documentação diretamente de profissionais para solicitar o medicamento.

“Foi o próprio médico que descobriu a trombofilia. Depois que ele viu os resultados dos exames, ele falou que eu poderia procurar na 9ª Regional. Ele também prescreveu o pedido e me encaminhou.” (M01).

“O médico do pré-natal de alto risco do CEM me deu toda a documentação para solicitar a medicação” (M04).

Entretanto, também houve relatos de ausência de orientação institucional, com informação obtida por redes sociais, amigas ou conhecimento profissional prévio.

“Como eu tenho formação em Serviço Social, eu já sabia que medicações de alto custo precisam ser solicitadas na 9ª Regional, mas todos os médicos me desencorajaram, falaram que é muito burocrático e difícil conseguir. Mesmo assim, insisti com meu médico atual. Levei o formulário, ele preencheu e estou entrando com o pedido” (M08).

“Só uma amiga que me falou dessa possibilidade. Só que eu nunca fui atrás porque eu consegui comprar pelo plano e também porque a minha Trombofilia é mais difícil de conseguir dizem” (M20).

Quanto ao desfecho do pedido na 9ª Regional, diante do questionamento “você conseguiu receber a Enoxaparina sódica pela 9ª Regional? Se sim, com quantas semanas? Caso não, por qual motivo?”, as falas evidenciaram negativas por critérios administrativos e socioeconômicos.

“Não, foi negado com a justificativa que, mediante a profissão e o teto salarial, eu teria condição de manter o tratamento. Sou enfermeira e meu esposo também. Me senti muito mal, porque não era verdade. Na minha época também não consegui pelo plano de saúde” (M12).

“Não. O pedido foi negado mesmo com critérios clínicos e laboratoriais. Em gestação anterior, quando judicializei, só recebi a medicação aos 8 meses. Disseram que eu não me encaixava no PCDT, pois não havia exames anteriores à gestação” (M4).

“Não consegui pelo SUS. Entrei com pedido pelo SUS e pelo plano,

mas ambos negaram. Só consegui depois, pela XXXXX¹, via processo judicial. Eles chegaram a me fornecer de forma emergencial 10 ampolas, depois mais 20, para eu não ficar sem. O motivo alegado foi que, apesar do histórico clínico, eu não atendia aos critérios laboratoriais exigidos pelo SUS” (M5).

A burocracia e demora apareceram como motivo de desistência e busca de alternativas no IT das mulheres entrevistadas.

“Não. Quando fui à 9ª Regional, estavam em período de férias e só retornariam em cerca de 20 dias. Nesse tempo, comecei a apresentar sangramentos e, por ter que ficar em repouso, desisti de tentar pelo órgão” (M03).

“Não, mas eu cheguei a tentar, só que foi indeferido porque eu tenho a empresa e está no nome, tenho plano de saúde. Enfim por ser empresária considerado que não precisava e por ter plano de saúde” (M19).

“Tinha que tomar logo após o positivo, minha médica orientou a iniciar imediatamente. Cheguei a comprar por conta, depois recebi pelo plano de saúde, com liberação total. Pela 9ª Regional, não cheguei a retirar disseram que havia muita burocracia interna e que o prazo de liberação podia chegar a 60 dias” (M09).

“Sim, mas apenas via Ministério Público. Descobri a gravidez em agosto e recebi o depósito em dezembro, quando já estava com quatro meses. Comprei as doses para dezembro, janeiro e fevereiro, e depois passei a retirar diretamente na 9ª Regional. A negativa foi porque, segundo a Regional, eu não tinha três abortos anteriores, critério exigido” (M07).

“Eu tive que entrar na justiça pela Defensoria Pública da União pra conseguir as injeções. Eu estava já de quatro meses quando recebi. Aí a (3ª gestação) já tava liberado, né (...) aí eu só precisei da documentação, fui na 9ª regional e já consegui pegar. Então foi um pouco mais fácil dessa 3ª vez” (M16).

No que se refere à orientação de uso, questionadas sobre “quem te orientou sobre como tomar a enoxaparina? E por quanto tempo você fez o uso da medicação?”, parte relatou que recebeu instruções médicas e outra parte descreveu aprendizado por redes de apoio.

¹ Na transcrição da entrevista da participante M5, o nome da empresa de saúde suplementar foi suprimido e substituído por “XXXX”, com o objetivo de preservar o anonimato da instituição e garantir a confidencialidade das informações, conforme os princípios éticos da pesquisa.

“Comecei a estudar sobre trombofilia, participar de grupos de WhatsApp e Facebook, e daí eu comecei a estudar e saber de tudo isso, onde, o que fazer, como aplicar, onde dói menos” (M02).

E:

“Ninguém orientou nada. Procurei na internet e em grupos de apoio. Depois, como eu ficava muito roxa nas aplicações, perguntei ao médico se estava aplicando errado. Ele disse que não, que era comum, e me orientou a variar os locais de aplicação. Sobre como conservar, ninguém falou nada” (M08).

6.1.5 Especificidades do território de fronteira no IT

No contexto das participantes vinculadas à 9ª Regional de Saúde, os relatos indicaram que o IT foi atravessado por características do arranjo regional de acesso, com centralidade do órgão regional no fluxo de solicitação e análise do medicamento e com repercussões práticas no tempo de resposta e na continuidade do cuidado. As falas evidenciaram que o processo de solicitação pode ser percebido como moroso, complexo e com incerteza de deferimento.

“(…) muita burocracia interna (...) prazo de liberação podia chegar a 60 dias” (M09).

“(…) lá (9ª Regional) é muita burocracia (...) não tem a atenção devida; atendimento ruim; quando vai buscar medicação o pessoal é ríspido, só entrega, não dá muito lado para escutar” (M15).

“(…) judicializei e em menos de 30 dias tive deferimento (...) depois da decisão judicial, comecei a receber pela 9ª Regional, mas havia falhas de controle. Recebi doses diferentes (40 mg, depois 60 mg) sem possibilidade de devolução ou ajuste. Cheguei até a doar medicamentos em excesso” (M18).

Além disso, indagadas “se você tivesse que orientar uma mulher para conseguir o medicamento na 9ª Regional de Saúde, como seria essa orientação?”, algumas participantes descreveram que o acesso à informação sobre fluxos e estratégias (como judicialização) circulou por redes de apoio e relações sociais, com menções diretas à necessidade de antecipar documentação e, simultaneamente, acionar instâncias jurídicas para evitar demora.

“(…) reunir todos os exames e laudos médicos, logo procurar a 9ª Regional de Saúde, mas já acionar um advogado ou o Ministério Público/Defensoria Pública para evitar demora. Explicar que acontece esse risco de “pingue-pongue” entre órgãos, por isso é importante agir

rápido judicialmente” (M02).

Uma participante trouxe à tona seu sentimento de indignação acerca das dificuldades de acesso e ausência de informações no processo de obtenção do medicamento através da 9ª Regional de Saúde.

“Naquele momento a única coisa que eu queria é que eu fosse bem-informada (...) ser direcionada corretamente (...) a gente espera, o mínimo de respeito, empatia e acolhimento (...) e que todas as informações sejam repassadas, que não fique nada omissa, que dificulte a informação, porque às vezes ela não sabe, mas estão informando que ela tem o direito, que o Estado é responsável por fornecer, enfim, ela tem que correr atrás dos papéis, mas que isso não seja um impasse para o acesso à informação é o direito dela do recebimento” (M01).

Outras falas apontaram percepção de inexistência de “caminho certo” formalizado, bem como a necessidade de profissionais qualificados no atendimento a gestante na rede pública de saúde.

“Que seja bem orientada por profissional de saúde. Muitas desistem por não saber quais documentos levar ou por falta de orientação. Porque cada mulher tenta dar um jeito, porque o caminho certo não existe” (M14).

“Eu diria para procurar um médico atualizado que investigue trombofilia adequadamente (...) o meu maior desafio foi conseguir um diagnóstico válido, já que precisei buscar fora. Sem diagnóstico, não teria direito ao medicamento” (M09).

A partir da análise das narrativas das participantes, os resultados evidenciaram ITs marcados por perdas gestacionais reiteradas, fragmentação do cuidado, dificuldades de acesso ao diagnóstico de trombofilia e barreiras institucionais para obtenção do tratamento com anticoagulante de alto custo. As falas revelaram a naturalização da perda gestacional nos serviços de saúde, a ausência de cuidado longitudinal e a necessidade de mobilização individual das mulheres para acessar exames, especialistas e medicamentos, muitas vezes por vias informais ou judiciais.

Além disso, as especificidades do território de fronteira atravessam esses IT, intensificando vulnerabilidades já existentes e expondo limitações organizacionais e programáticas da rede de atenção à saúde. Os achados apresentados neste capítulo oferecem,

portanto, subsídios empíricos para a análise crítica dessas experiências à luz da literatura científica, das políticas públicas e dos protocolos vigentes, discussão que será desenvolvida no capítulo seguinte.

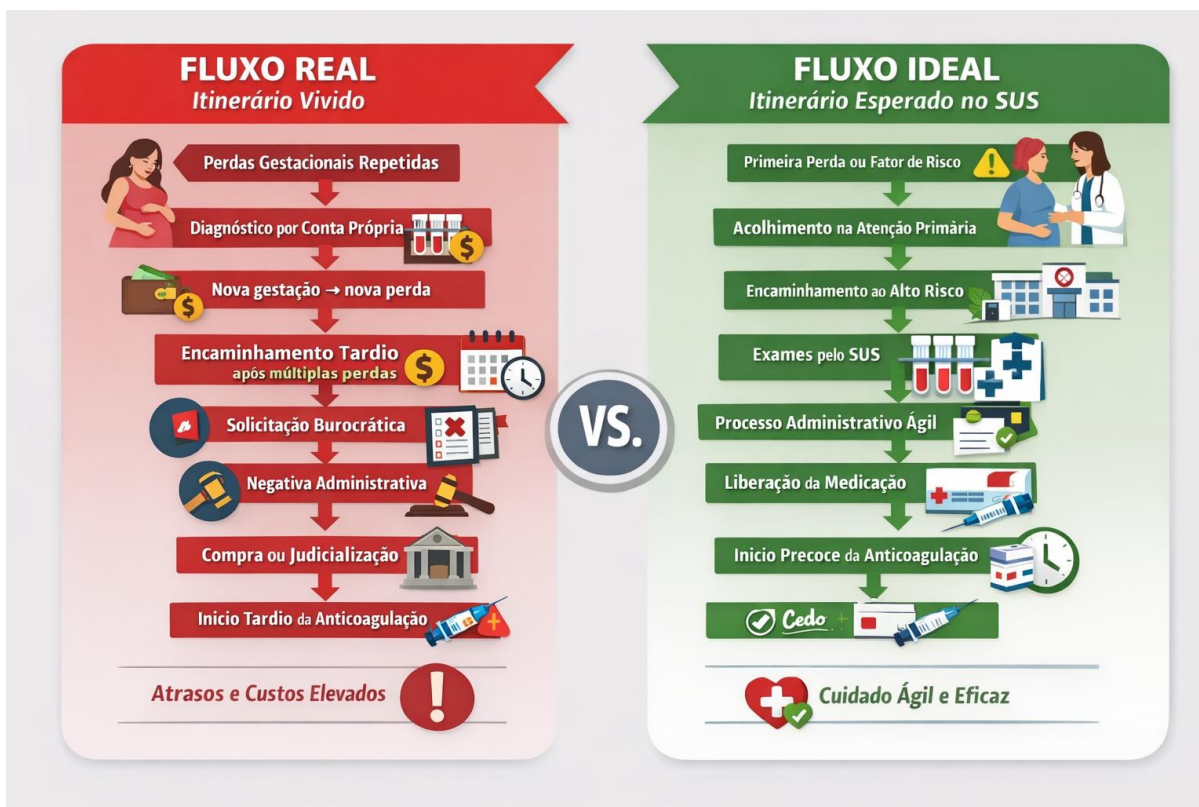
6.2 SÍNTESE DO IT: CONSTRUÇÃO DO MAPA FALADO

O IT é entendido como o conjunto de caminhos que os indivíduos constroem na busca por cuidados, influenciado por dimensões institucionais, sociais e simbólicas, que nem sempre se alinham aos fluxos formalmente estabelecidos pelos sistemas de saúde (Kleinman, 1980; Cabral *et al.*, 2011).

Com a finalidade de integrar e tornar compreensível o conjunto das experiências relatadas pelas participantes, foi elaborado um mapa falado do IT das gestantes que necessitaram do uso de anticoagulantes em um município de fronteira. Essa representação gráfico-narrativa sintetiza o percurso assistencial vivenciado pelas mulheres no SUS, desde a ocorrência da perda gestacional até o acesso, muitas vezes tardio, à anticoagulação, destacando os principais pontos de ruptura, as barreiras institucionais e as estratégias informais utilizadas ao longo do cuidado.

O mapa sintetiza o IT construído a partir das narrativas das participantes (Figura 2), evidenciando os principais pontos de fragmentação do cuidado, as barreiras institucionais e as estratégias informais de acesso ao tratamento, em contraste com o fluxo ideal sugerido pelos protocolos assistenciais.

Figura 2 – Mapa falado do IT de gestantes que demandam uso de anticoagulantes durante a gestação na 9ª regional de saúde de Foz do Iguaçu, PR, de 2015 a 2015: fluxo real e fluxo ideal



Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa (2026).

O mapa falado não é apenas um instrumento ilustrativo, mas sim um produto analítico, desenvolvido a partir da interpretação das entrevistas e da conexão entre os eixos temáticos que emergem da análise de conteúdo. Sua criação se baseia na compreensão de que o IT é um processo dinâmico, influenciado por determinantes institucionais, sociais, territoriais e simbólicos, que vão além da linearidade dos protocolos assistenciais e mostram as maneiras concretas pelas quais o cuidado é vivenciado.

6.2.1 O IT real: fragmentação, atrasos e responsabilização da mulher

O mapa falado do IT real mostra que o percurso assistencial das gestantes é, em sua maioria, caracterizado pela naturalização da perda gestacional, pela falta de investigação clínica precoce e pela descontinuidade do cuidado. A perda gestacional é vista como o evento inicial do IT, frequentemente interpretado pelos profissionais como algo comum ou esperado,

especialmente quando ocorre no primeiro trimestre, resultando na ausência de orientações sistemáticas e a não realização de exames diagnósticos iniciais.

Essa naturalização atua como um mecanismo institucional que adia o cuidado, transferindo a possibilidade de investigação para momentos posteriores, geralmente condicionados à repetição do evento adverso. Como consequência, muitas mulheres enfrentam novas gestações e novas perdas antes de qualquer encaminhamento especializado, aumentando o sofrimento físico e emocional e atrasando intervenções que poderiam ser preventivas.

No mapa, esse percurso é representado por setas interrompidas e retornos constantes, simbolizando a não linearidade do cuidado. O encaminhamento ao especialista ocorre de forma tardia e irregular, frequentemente após duas ou três perdas gestacionais, e não se insere em um fluxo institucional coordenado. Pelo contrário, o cuidado se fragmenta entre diferentes profissionais e serviços, com frequentes trocas de médicos e falta de acompanhamento longitudinal.

Nesse contexto, a mulher desempenha um papel fundamental na organização do seu próprio cuidado. O mapa falado destaca a transferência da coordenação assistencial para a gestante, que começa a buscar informações, solicitar exames, identificar especialistas e entender, por conta própria, os trâmites administrativos necessários para acessar o tratamento. Essa busca ativa é frequentemente mediada por redes informais, como grupos de apoio, redes sociais e recomendações de outras mulheres, revelando lacunas significativas na comunicação institucional e no acolhimento pelos serviços de saúde.

A realização de exames laboratoriais, essenciais para a confirmação diagnóstica de trombofilia, aparece no mapa como um ponto crítico do IT real. Diante da indisponibilidade ou demora na oferta desses exames pelo SUS, muitas participantes optam por pagar diretamente ou utilizar planos de saúde, mesmo que nem sempre consigam realizar todos os testes exigidos pelos protocolos. O diagnóstico, quando ocorre, é frequentemente incompleto ou tardio, o que compromete o acesso ao medicamento de alto custo. O acesso à anticoagulação, especialmente à enoxaparina sódica, se configura como uma das etapas mais complexas do IT real.

O mapa falado destaca a existência de diversas barreiras administrativas, como a exigência de documentos, critérios restritivos, negativas formais e longos períodos de espera. Diante dessas dificuldades, as mulheres adotam estratégias extremas, como a compra do medicamento com recursos próprios ou a judicialização do acesso, o que reforça a percepção de um sistema pouco responsivo às necessidades de cuidado em tempo hábil.

Como resultado desse percurso, o início da anticoagulação ocorre, em muitos casos, de

forma tardia, diminuindo seu potencial preventivo e aumentando a sensação de insegurança gestacional. O mapa falado, ao integrar esses elementos, mostra que o IT real não se organiza como uma linha de cuidado, mas sim como um conjunto de tentativas, desvios e resistências, sustentado principalmente pelo esforço individual das gestantes.

6.2.2 O IT ideal: coordenação, integralidade e cuidado oportuno

Em contraste com o percurso real, o mapa falado incorpora o IT ideal, que é construído a partir de protocolos clínicos, diretrizes institucionais e princípios organizadores do SUS. Esse fluxo ideal começa com a primeira perda gestacional ou a identificação de fatores de risco, que deveriam ativar mecanismos de acolhimento, registro longitudinal e estratificação de risco na APS.

No IT ideal, a APS desempenha seu papel como coordenadora do cuidado, assegurando o encaminhamento precoce para o pré-natal de alto risco e a solicitação de exames laboratoriais conforme o PCDT, por meio da regulação do SUS. A confirmação do diagnóstico ocorre de maneira oportuna, permitindo a abertura de um processo administrativo completo, com laudos, exames e formulários padronizados, que será avaliado pela Regional de Saúde.

Nesse fluxo, a resposta institucional é ágil e resolutiva, resultando na liberação da enoxaparina e no início precoce da anticoagulação, com acompanhamento contínuo e articulado entre a APS e os serviços especializados. Assim, o mapa ideal representa uma linha de cuidado estruturada, fundamentada na integralidade, na longitudinalidade e na equidade de acesso.

6.2.3 O mapa falado como síntese crítica do cuidado em saúde

A justaposição entre o percurso real e o ideal, apresentada no mapa falado, destaca um descompasso significativo entre o cuidado que é prescrito e o cuidado que é realmente vivido. Enquanto o fluxo ideal pressupõe uma coordenação institucional e respostas rápidas, o fluxo real revela fragmentação, atrasos e a sobrecarga da mulher como principal responsável pela organização do cuidado.

Do ponto de vista analítico, o mapa falado esclarece que as barreiras enfrentadas pelas gestantes não se limitam a falhas pontuais, mas refletem problemas estruturais na organização da rede de atenção, que são agravados pelas particularidades do território de fronteira. A presença de uma população flutuante, as dificuldades de registro formal, os limites

administrativos e a escassez de recursos contribuem para a criação de ITs instáveis e pouco eficazes.

Além disso, o mapa mostra que o sofrimento vivido pelas mulheres não decorre apenas das perdas gestacionais em si, mas também da maneira como o sistema de saúde responde, ou falha em responder, a essas experiências. A falta de acolhimento, a repetição de negativas e a necessidade de judicialização configuram um cenário de desgaste emocional e institucional que impacta diretamente a experiência da gestação.

Ao integrar narrativas, fluxos assistenciais e uma análise crítica, o mapa falado se estabelece como uma ferramenta poderosa para entender o percurso terapêutico em sua complexidade, permitindo visualizar não apenas os caminhos trilhados, mas também os silêncios, interrupções e desigualdades que permeiam o cuidado em saúde. Sua utilização em pesquisas ajuda a ampliar a compreensão sobre os desafios do acesso à anticoagulação em gestantes em regiões de fronteira e fornece subsídios para refletir sobre a necessidade de reorganização dos fluxos assistenciais, fortalecimento da APS e qualificação do cuidado longitudinal.

7 DISCUSSÃO

7.1 CATEGORIA 1 – A PERDA GESTACIONAL COMO EVENTO NATURALIZADO

Os achados evidenciam que a perda gestacional, especialmente quando precoce, tende a ser enquadrada nos serviços como evento biologicamente esperado, o que pode retardar investigações clínicas e fragilizar o acolhimento. Tal prática contrasta com a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, que estabelece a necessidade de cuidado integral, escuta qualificada e orientação reprodutiva independentemente da idade gestacional (Brasil, 2011).

No âmbito das políticas públicas, diretrizes como a PNAISM e a RC reforçam que situações de perda devem desencadear seguimento longitudinal e articulação com APS, assegurando continuidade do cuidado e suporte psicossocial (Brasil, 2011; Brasil, 2023). Entretanto, quando a perda é tratada como evento isolado e autolimitado, a investigação de possíveis fatores associados a como trombofilia tende a ser postergada, configurando uma lógica reativa em detrimento de uma abordagem preventiva.

A literatura nacional e internacional indica que a perda gestacional, embora relativamente comum do ponto de vista epidemiológico, não deve ser vista como um evento comum ou sem significado. Pesquisas apontam que a experiência da perda é vivenciada pelas mulheres como uma interrupção brusca e traumática de sonhos e planos idealizados, resultando em um processo profundamente doloroso que gera sentimentos de choque, tristeza extrema e vazio. Frequentemente, essa dor é acompanhada por uma forte sensação de incapacidade, culpa e autorrecriação, em que a mulher pode se sentir falha por não ter conseguido manter a viabilidade da gestação, o que frequentemente desencadeia quadros de ansiedade, solidão, depressão, insegurança reprodutiva e medo de novas gestações, especialmente quando não há explicações adequadas ou suporte institucional (Silva *et al.*, 2020; Ferreira *et al.*, 2021; Mendonça *et al.*, 2024; Coêlho *et al.*, 2025).

Estudos em saúde coletiva indicam que a perda gestacional enfrenta uma forte tendência de subestimação e banalização social, o que frequentemente descaracteriza a gravidade do sofrimento para a mulher e sua família (Nunes *et al.*, 2024). Essa realidade é agravada por modelos de atendimento mecanicistas e tecnicistas, que concentram o cuidado quase exclusivamente no evento biológico e na doença, desconsiderando as dimensões emocionais, humanas e o suporte psíquico necessário durante o processo. A literatura indica uma tendência dos profissionais ao distanciamento emocional como uma estratégia de autoproteção para

manejar o desconforto e a ansiedade gerados pela situação de morte, o que sinaliza um profundo despreparo para lidar com perdas gestacionais (Morais *et al.*, 2024; Pantoja *et al.*, 2025; Finger *et al.*, 2025).

Do ponto de vista da gestão, é fundamental estabelecer fluxos assistenciais claros para o acompanhamento pós-perda, incluindo orientações sobre reprodução, avaliações clínicas individualizadas e intervenções oportunas quando necessário. A adoção de protocolos locais que estejam alinhados com diretrizes nacionais, sem restringir o cuidado a critérios puramente biomédicos, pode ajudar a superar a naturalização da perda gestacional e promover um atendimento mais humano, equitativo e integral.

7.2 CATEGORIA 2 – OS ITS FRAGMENTADOS

Diante da ausência de fluxos claros e de acompanhamento contínuo, as mulheres passaram, de maneira gradual, a assumir o papel de organizadoras do seu próprio cuidado, agendando consultas, exames e especialistas por conta própria. Esse processo gerou desgaste físico e emocional, insegurança clínica e a sensação de estar em uma jornada pelos serviços, tornando o cuidado uma experiência solitária e instável.

De acordo com as diretrizes do SUS, a atenção à gestação, especialmente nos casos de risco, deve ser organizada por meio de Redes de Atenção à Saúde e fundamentada no Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), visando superar o modelo fragmentado e reativo. Um pilar central é a estratificação de risco gestacional, que deve ser realizada na primeira consulta e atualizada em todos os atendimentos subsequentes, classificando as mulheres em risco habitual, intermediário ou alto risco para direcionar a intensidade do cuidado necessária. A RC, reestruturada em 2023, determina que a APS deve atuar como coordenadora do cuidado, assegurando vínculo, seguimento longitudinal e articulação com a atenção especializada, especialmente em situações de perdas gestacionais recorrentes e condições clínicas complexas (Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, 2019; Brasil, 2011; Brasil, 2023).

Para os casos de gestação de alto risco, que representam cerca de 15% das grávidas, a recomendação central das diretrizes do SUS é o cuidado compartilhado entre as equipes da APS e da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), mantendo a vinculação da gestante ao seu território enquanto recebe suporte especializado. O papel da equipe multiprofissional interdisciplinar, composta obrigatoriamente por médicos obstetras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fisioterapeutas, é realizar uma avaliação diagnóstica abrangente e estabelecer um plano de cuidados único focado na estabilização clínica e na

mitigação de riscos (Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, 2019).

Pesquisadores confirmam que a fragmentação do cuidado no SUS leva os usuários a uma exaustiva peregrinação, na qual a falha da rede em coordenar a assistência os obriga a traçar trajetórias autônomas baseadas em tentativas e deslocamentos para resolver seus problemas de saúde (Anunciação *et al.*, 2019). Esse cenário reflete uma rede frequentemente descrita como desarticulada e assimétrica, onde a falta de integração entre os serviços resulta na descontinuidade do cuidado e no agravamento de condições clínicas (Belga; Jorge; Silva, 2022).

Especialmente em casos de alta vulnerabilidade, como abortos ou situações de risco, as mulheres enfrentam ITs repletos de barreiras institucionais e julgamentos morais, navegando por trilhas de múltiplos caminhos em busca de apoio. Analiticamente, esse protagonismo forçado do usuário resulta na formação de redes vivas, onde os percursos assistenciais são moldados pelas necessidades e urgências do dia a dia, em resposta à ineficiência das redes formais de atenção (Fonseca *et al.*, 2024).

Assim, a fragmentação observada não constitui falha pontual, mas expressão de limitações estruturais na coordenação do cuidado, tensionando os princípios de integralidade e continuidade preconizados pelo SUS.

7.3 CATEGORIA 3 – AS BARREIRAS DE ACESSO AO DIAGNÓSTICO

O acesso ao diagnóstico de trombofilia, quando condicionado a critérios restritivos e oferta limitada de exames, pode operar como filtro seletivo para o próprio acesso ao tratamento. Embora o PCDT estabeleça parâmetros técnicos para investigação, sua aplicação descontextualizada pode produzir atrasos diagnósticos e reforçar desigualdades programáticas (Nascimento *et al.*, 2019).

Nesse cenário ideal, a APS deve atuar como a porta de entrada e o centro de comunicação da rede, realizando a estratificação de risco e o compartilhamento do cuidado com a AAE de maneira ágil e proativa. A assistência deve ser pautada na humanização, oferecendo escuta qualificada e suporte emocional que minimizem a ansiedade e a vulnerabilidade da gestante. Portanto, a linha de cuidado deve assegurar que a comunicação entre os diferentes níveis de atenção seja fluida e que o tratamento profilático, como o uso de enoxaparina, seja disponibilizado prontamente conforme as necessidades clínicas, eliminando barreiras institucionais que levam ao autofinanciamento ou à judicialização do diagnóstico (Sociedade

Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, 2019).

A literatura aponta que a judicialização da saúde no Brasil é frequentemente o resultado de uma desarticulação entre a necessidade individual de tratamento e a organização das políticas públicas. O conceito de bioética da justiça é convocado para discutir o equilíbrio entre a microjustiça (atender o caso específico de uma gestante) e a macrojustiça (garantir a equidade e a sustentabilidade para toda a população) (Chaves; Poças; Scherer, 2024). Quando o sistema falha em prover o acesso a medicamentos de alto custo, como a enoxaparina, ou a exames laboratoriais necessários, as mulheres são forçadas a recorrer ao Judiciário, transformando uma necessidade clínica em um litígio legal para assegurar o binômio mãe-filho (Mendonça *et al.*, 2024).

O subdiagnóstico da trombofilia é uma realidade recorrente, muitas vezes porque a condição é negligenciada por profissionais de saúde até que ocorram eventos tromboembólicos graves ou perdas gestacionais sucessivas (Cieslinsky *et al.*, 2024). Estudos mostram que os protocolos clínicos atuais, que muitas vezes exigem três perdas gestacionais consecutivas para iniciar uma investigação pelo SUS, são percebidos pelas mulheres como desumanos e tecnicamente limitados, pois ignoram o impacto traumático do luto e da saúde mental. Essa prática institucionaliza o atraso assistencial, impedindo que causas tratáveis sejam identificadas em tempo oportuno, o que aumenta a vulnerabilidade da gestante (Anunciação *et al.*, 2019; Perez *et al.*, 2024).

A capacitação profissional deve ir além do conhecimento técnico, focando no aprimoramento do letramento em saúde e na competência relacional das equipes (Silva *et al.*, 2020). A literatura revela que muitos profissionais mantêm atitudes mecanicistas ou insensíveis, desvalorizando a percepção da gestante sobre seu próprio corpo (Ferreira *et al.*, 2021; Coêlho *et al.*, 2025).

Sendo a barreira econômica é um dos obstáculos mais críticos citados na literatura. Como os testes de trombofilia e o tratamento profilático possuem alto custo, o acesso ao diagnóstico acaba dependendo da capacidade financeira individual, resultando em um cenário de exclusão para as mulheres de estratos sociais mais baixos. Assim, a literatura sugere que os direitos reprodutivos só se efetivarão plenamente quando o sistema eliminar esses filtros seletivos e garantir que o diagnóstico não seja um ônus financeiro para a mulher (Fonseca *et al.*, 2024; Cieslinsky *et al.*, 2024).

7.4 CATEGORIA 4 – O ACESSO AO ANTICOAGULANTE DE ALTO CUSTO

O acesso à enoxaparina sódica evidencia fragilidades na operacionalização da assistência farmacêutica especializada, particularmente no que se refere à previsibilidade e à celeridade de fornecimento. Embora o PCDT estabeleça critérios técnicos para dispensação e continuidade terapêutica, sua efetivação depende de arranjos locais de gestão e regulação, resultando em variações operacionais (Rover *et al.*, 2021; Soares *et al.*, 2024).

A literatura científica destaca que a enoxaparina sódica é o anticoagulante de escolha para a profilaxia da trombofilia gestacional, sendo essencial para prevenir eventos tromboembólicos e perdas gestacionais recorrentes. No entanto, os autores ressaltam que o acesso a essa medicação é frequentemente dificultado por seu alto custo, que pode chegar a aproximadamente R\$ 1.500,00 mensais, tornando o tratamento dependente da capacidade financeira individual (Perez *et al.*, 2024; Osorio-De-Castro *et al.*, 2025). Na prática, as mulheres enfrentam um percurso complexo no SUS, marcado por protocolos restritivos que muitas vezes excluem trombofilias hereditárias específicas ou exigem processos burocráticos lentos, resultando em insegurança emocional e na necessidade de autofinanciamento ou fracionamento perigoso de doses para manter a terapia.

A literatura científica ratifica que o acesso à enoxaparina sódica no SUS é marcado por um descompasso entre as diretrizes nacionais e a operacionalização local. Embora existam protocolos clínicos definidos, como o PCDT, a obtenção do medicamento depende fortemente de arranjos de gestão locais, o que gera variações significativas nos tempos de liberação e nos critérios operacionais (Rover *et al.*, 2021). Essa fragmentação transforma o tratamento, que deveria ser a continuidade natural do cuidado pós-diagnóstico, em uma etapa crítica e vulnerabilizadora, forçando as mulheres a um percurso incerto para garantir a segurança gestacional (Soares *et al.*, 2024; Perez *et al.*, 2024).

Estudos apontam que a medicação, essencial para evitar eventos tromboembólicos e perdas fetais, muitas vezes deixa de ser um direito assegurado para se tornar um recurso de difícil obtenção. A literatura destaca que o início da anticoagulação ocorre frequentemente de forma tardia e fragmentada, mesmo após o reconhecimento do risco clínico (Moroi *et al.*, 2024).

Do ponto de vista psicoemocional, a literatura descreve que a incerteza no acesso gera um estado de insegurança e sofrimento prolongado. O receio de interrupção do tratamento por falhas administrativas cria um cenário de medo constante de perdas evitáveis, impactando severamente a saúde mental da gestante (Alves; Santos; Amoroso, 2025). Assim, o acesso ao anticoagulante emerge como um marcador de desigualdade institucional, onde a trajetória individual é marcada por um desgaste emocional que sobrepõe o ônus da gestão do risco à

própria paciente.

Por fim, a fragilidade na coordenação do cuidado entre os diferentes níveis da RAS compromete a eficácia da política pública. A desarticulação entre a APS e os serviços especializados, somada à demora administrativa, interrompe a linha de cuidado necessária para o binômio mãe-filho (Boing *et al.*, 2022). Para que a resolubilidade seja efetiva, a literatura sugere que o acesso ao medicamento deve ser desburocratizado e garantido como um dever do Estado, eliminando os obstáculos que transformam uma necessidade clínica em um litígio ou em um sacrifício financeiro individual (Vieira *et al.*, 2025).

7.5 CATEGORIA 5 – AS ESPECIFICIDADES DO TERRITÓRIO DE FRONTEIRA

O descompasso entre as normas estabelecidas e a prática assistencial em região de fronteira se revela na dificuldade da rede em atender de maneira contínua e eficaz as demandas dos usuários. Na realidade, a falta de políticas permanentes de financiamento específicas para a fronteira, aliada à alta rotatividade populacional, gera obstáculos na organização dos fluxos de cuidado, na regulação de exames e na disponibilização de medicamentos, sobretudo os de alto custo (Arenhart; González, 2025). Além disso, a fronteira destaca uma forma ampliada de vulnerabilidade programática, onde as limitações institucionais se sobrepõem às necessidades clínicas (Antoine; Arenhart; David, 2025).

A literatura sobre saúde em áreas de fronteira ressalta que esses territórios enfrentam desafios específicos relacionados à mobilidade da população, à subnotificação de demandas e à falta de mecanismos de compensação financeira entre os diferentes níveis de governo (Xavier *et al.*, 2022). A ausência de políticas estruturais de longo prazo para a fronteira resulta em redes de atenção fragilizadas, com baixa capacidade de coordenação do cuidado e dificuldades para garantir acesso a serviços especializados e insumos essenciais (Arenhart *et al.*, 2020).

Nesse contexto, a literatura ajuda a entender por que, mesmo em um sistema de saúde universal, gestantes em regiões de fronteira enfrentam barreiras maiores para acessar cuidados de alta complexidade, como o diagnóstico e tratamento da trombofilia, enfatizando a necessidade de abordagens territoriais diferenciadas (De Mello; Mapelli; De Oliveira Gozzo, 2024).

Dessa forma, o território não se configura apenas como contexto geográfico, mas como elemento estruturante do acesso, exigindo políticas diferenciadas e fortalecimento da APS como coordenadora do cuidado em cenários de maior complexidade organizacional.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados evidenciam que, para mulheres que demandam tratamento com anticoagulantes em contexto de região de fronteira, o acesso ao cuidado em saúde se configura como limitado, fragmentado e, em muitos casos, tardio. O IT reconstruído a partir das narrativas revelou obstáculos significativos em diferentes etapas do percurso assistencial, iniciando-se pela naturalização da perda gestacional, passando pela busca autônoma por exames e diagnóstico, até a necessidade de custear, com recursos próprios, medicamentos de alto custo diante do indeferimento das solicitações formais pelos serviços públicos de saúde.

Esse percurso foi marcado por inseguranças, desinformação e lacunas assistenciais, que frequentemente culminaram na judicialização do acesso ao tratamento ou na necessidade de acionar o Ministério Público como estratégia para garantir um direito constitucional à saúde. Tais experiências evidenciam a transferência da responsabilidade pelo cuidado às próprias mulheres, que passam a assumir, de forma individualizada, a condução de processos que deveriam ser assegurados e coordenados pelo sistema de saúde.

Os relatos também expuseram fragilidades estruturais na APS, caracterizadas pela ausência de fluxos assistenciais claros, falhas na estratificação de risco e indisponibilidade, no âmbito do Sistema Único de Saúde, de exames essenciais para o diagnóstico das trombofilias. Destaca-se, ainda, que os critérios atualmente estabelecidos pelo PCDT ao restringirem o acesso à anticoagulação apenas a mulheres com diagnóstico confirmado e histórico de três ou mais perdas gestacionais, desconsideram quadros clínicos sugestivos e contextos de vulnerabilidade social. Essa condição expõe as mulheres a novos episódios de perda, sofrimento físico e emocional, reforçando a necessidade urgente de revisão desses protocolos, com ampliação da análise de risco para além de critérios exclusivamente laboratoriais, incorporando dimensões clínicas, sociais e territoriais.

No que se refere às limitações da pesquisa, ressalta-se a dificuldade de acesso a informações institucionais que possibilitassem a identificação direta dos potenciais participantes, o que demandou a adoção de estratégias alternativas de recrutamento. Embora o número de entrevistadas tenha sido adequado para um estudo qualitativo, tal aspecto limita a generalização dos achados, devendo ser considerado na interpretação dos resultados.

Apesar dessas limitações, esta pesquisa apresenta contribuição relevante ao conferir voz e visibilidade às experiências de mulheres que vivenciam o cuidado em saúde em territórios de fronteira, ainda pouco explorados na literatura científica. Ao reunir narrativas que evidenciam

tanto as falhas do sistema quanto a resiliência individual na busca por cuidado, o estudo oferece subsídios consistentes para o aprimoramento de políticas públicas voltadas à saúde materna de alto risco, com ênfase na equidade de acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

Recomenda-se que pesquisas futuras ampliem a discussão para outros territórios fronteiriços, incluindo a perspectiva de profissionais da rede de saúde, bem como o desenvolvimento de estudos longitudinais capazes de avaliar o impacto dessas barreiras nos desfechos gestacionais. A partir das evidências aqui apresentadas, espera-se contribuir para a construção de ITs mais justos, acessíveis e sensíveis às reais necessidades das mulheres em situação de vulnerabilidade, fortalecendo o cuidado integral e a responsabilidade do sistema de saúde na garantia desse direito.

REFERÊNCIAS

- AIKES, S.; RIZZOTTO, M. L. F. Integração regional em cidades gêmeas do Paraná, Brasil, no âmbito da saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, p. e00182117, 20 ago. 2018.
- AIKES, S.; RIZZOTTO, M. L. F. O Direito à Saúde do Transfronteiriço nas Cidades Gêmeas do Paraná. **Sociedade em Debate**, v. 25, n. 1 esp., p. 144-157, 2019.
- ALVES, A.; SANTOS, M.; AMOROSO, S. Desafios à saúde mental de gestantes: do pré-natal ao puerpério (psicologia). **Repositório Institucional**, v. 3, n. 2, 2025.
- ANTOINE, J. A.; ARENHART, C. G. M.; DAVID, J. B. Atenção à saúde para mulheres imigrantes na fronteira trinacional: olhares e experiências. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, v. 6, n. 7, p. e676594-e676594, 2025.
- ANUNCIAÇÃO, P. S. *et al.* “Revés de um parto”: relatos de mulheres que perderam o filho no período neonatal. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, p. e00190517, 2019.
- APARECIDA, V.; QUAGLIO, M.; ALVES TEREZINHA, K.; FRANCO, S.; APARECIDA, L.; NEVES, E. Rede Cegonha na visão de gestantes e profissionais: Uso de grupo focal e entrevista. **New Trends in Qualitative Research**, v. 8, p. 591-599, 2021.
- ARAÚJO, Á. C. de; VIEIRA, L. J. E. de S.; FERREIRA JÚNIOR, A. R.; PINTO, A. G. A.; FREITAS, K. M. de; RIBEIRO, C. L. Processo de trabalho para coordenação do cuidado na Estratégia de Saúde da Família. **Escola Anna Nery**, v. 27, p. e20220330, 2023.
- ARENHART, C. G. M. *et al.* O acesso à saúde na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai: o que dizem as pessoas usuárias dos sistemas de saúde? **Boletim De Conjuntura (BOCA)**. ano II, vol. 4, n. 11, Boa Vista, 2020.
- ARENHART, C. G. M.; GONZÁLEZ, A. D. Disputa cidadã por políticas sociais de saúde em território transfronteiriço: um espaço-entre a ser transformado. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 35, p. e350337, 2025.
- BAPTISTA, F. S.; OLIVEIRA, A. L. M. L. Trombofilias. In: ZUGAIB, M.; BITTAR, R. E. Protocolos assistenciais: **Clínica Obstétrica FMUSP**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. p. 193-204.
- BELGA, S. M. M. F.; JORGE, A. O.; SILVA, K. L. Continuidade do cuidado a partir do hospital: interdisciplinaridade e dispositivos para integralidade na rede de atenção à saúde. **Saúde em Debate**, v. 46, p. 551-570, 2022.
- BENDER, J. D.; FACCHINI, L. A.; LAPÃO, L. M. V.; TOMASI, E.; THUMÉ, E. Avaliação dos recursos humanos na Atenção Primária à Saúde: o caso brasileiro de 2012 a 2018. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 40, p. e00011024, 14 jun. 2024a.
- BENDER, J. D.; FACCHINI, L. A.; LAPÃO, L. M. V.; TOMASI, E.; THUMÉ, E. Evolução da disponibilidade de Tecnologias de Informação e Comunicação na Atenção Primária à Saúde do Brasil, 2012 a 2018. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 27, p. e240021, 19

abr. 2024b.

BIAGE, K. X. G.; SILVA, G. S. V.; RICCI, A. Q.; SOUSA, A. S.; GOMES, E. N. F.; SILVA, J. S. L. G. Assistência de enfermagem no pré-natal de gestantes com trombofilia na Atenção Primária de Saúde. **Revista Pró-UniverSUS**, v. 14, n. 1, p. 15-20, 2023.

BIERNACKI, P.; WALDORF, D. Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral sampling. **Sociological methods & research**, v. 10, n. 2, p. 141-163, 1981.

BOING, A. C. *et al.* Prevalências e desigualdades no acesso aos medicamentos por usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil em 2013 e 2019. **Cadernos de saúde publica**, v. 38, p. e00114721, 2022.

BRASIL. DATASUS - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil. **Óbito de Mulheres por Gravidez/Puerpério Segundo Região**. 2018. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/mat10uf.def>. Acesso em: 07 jul. 2025.

BRASIL. Diário Oficial da União. **Brasília: Imprensa Nacional**, 03 jun. 2024. Seção 1, p. 1. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/06/2024&jornal=515&pagina=1>. Acesso em: 23 jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979. **Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências**. Diário Oficial da União, 2 maio 1979.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Gabinete do Ministro. Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 13 de janeiro de 2023**. Revoga Portarias que especifica e dá outras providências. A Portarias GM/MS nº 715, de 4 de abril de 2022, que "Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, para instituir a Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami)".

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 715 de 04 de abril de 2022**. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, para instituir a Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami). Diário Oficial da União. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 622, de 23 de abril de 2014**. Dispõe sobre os prazos para conclusão da implementação das ações previstas no Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS Fronteiras) e sobre o repasse de incentivo financeiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia**. 2021. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Regiões de Saúde**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/programa-cuida-mais-brasil/regioes-de->

saude. Acesso em: 29 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução CIT nº 1, de 29 de setembro de 2011**. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2011/res0001_29_09_2011.html. Acesso em: 29 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção à Saúde**. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas. **Manual de gestação de alto risco**. 2022; 490-502.

BRITO, P. N.; PEREIRA, T. C. F.; NEVES NETO, D. N. D.; RIBEIRO, C. Z. Atenção básica: indicadores de Saúde da Mulher no Estado do Tocantins, Brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, 30, 407-415, 2022.

CABRAL, A. L. L. V. *et al.* Itinerários terapêuticos: o estado da arte da produção científica no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 11, p. 4433-4442, 2011.

CHAVES, A. C. C.; POÇAS, K. C.; SCHERER, M. D. A. Quem faz uma Atenção Primária resolutive? Governança para a efetividade na resolução de problemas. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 22, p. e02868275, 2024.

CIESLINSKY, T. F. *et al.* Influência de medicamentos anticoagulantes na trombofilia gestacional: uma revisão sistemática. **Saúde Pesqui.(Online)**, p. 12767-12767, 2024.

COÊLHO, L. P. I. *et al.* Mulheres que vivenciaram o processo de abortamento: necessidades de orientações para os cuidados. **Enferm. foco (Brasília)**, p. 1-8, 2025.

CORAL-ALMEIDA, M.; SÁNCHEZ, M. E.; HENRÍQUEZ-TRUJILLO, A. R.; *et al.* Ethnic, geographical and altitude considerations and maternal mortality associated with HELLP syndrome in Ecuador: a population-based cohort study. **BMC Pregnancy Childbirth** 24, 585 2024.

DA ROSA, B. G. Perda gestacional: Aspectos emocionais da mulher e o suporte da família na elaboração do luto. **Revista PsicoFAE: Pluralidades em Saúde Mental**, v. 9, n. 2, p. 86-99, 2020.

DE MELLO, F.; MAPELLI, L. D.; DE OLIVEIRA GOZZO, T. Desafios de la atención obstétrica en las regiones fronterizas de Brasil/Paraguay: percepciones de brasiguaias. **Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde (REAS)**, v. 14, n. 1, 2024.

DEMÉTRIO, F.; SANTANA, E. R. de; PEREIRA-SANTOS, M. O itinerário terapêutico no Brasil: revisão sistemática e metassíntese a partir das concepções negativa e positiva de saúde. **Saúde em Debate**, v. 43, n. spe7, p. 204–221, 2019.

DICKS, A. B.; MOUSSALLEM, E.; STANBRO, M.; WALLS, J.; GANDHI, S.; GRAY, B. H. A comprehensive review of risk factors and thrombophilia evaluation in venous thromboembolism. **Journal of Clinical Medicine**, v. 13, n. 2, p. 362, 2024.

FAREED, J.; HOPPENSTEADT, D.; WALENGA, J.; IQBAL, O.; MA, Q.; JESKE, W.; SHEIKH, T. Pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of enoxaparin: implications for clinical practice. **Clin Pharmacokinet**, Auckland, v. 42, n. 12, p. 1043-1057, 2003.

FATEL, K. D. O.; ROVER, M. R. M.; MENDES, S. J.; LEITE, S. N.; STORPIRTIS, S. Desafios na gestão de medicamentos de alto preço no SUS: avaliação da Assistência Farmacêutica em São Paulo, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 11, p. 5481-5498, 2021.

FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Trombofilias e gravidez. São Paulo: FEBRASGO, 2020. Protocolo FEBRASGO-Obstetrícia, n. 67/Comissão Nacional Especializada em Tromboembolismo Venoso. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/images/pec/anticoncepcao/n67---O---Trombofilias-e-gravidez.pdf>. Acesso em: 18 de set. de 2024.

FERREIRA, C. M.; FIGUEIRÓ-FILHO, E. A.; OLIVEIRA, V. M. D.; PEREIRA, É. F. D. V. Thromboprophylaxis and maternal-fetal outcomes of women with serum markers for hereditary thrombophilia and previous obstetric complications. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 17, n. 4, p. 693-698, dez. 2017.

FERREIRA, R. S. A. *et al.* Assistência dos profissionais de saúde em situação de perda gestacional: revisão integrativa. **REME-Revista Mineira de Enfermagem**, v. 25, n. 1, 2021.

FINGER, D. *et al.* Atuação de enfermeiros no pré-natal de risco habitual: contribuições da realização de grupos de gestantes. **Enferm. foco (Brasília)**, p. 1-7, 2025.

FONSECA, J. G. *et al.* Intersecção entre dificuldades de acesso e violência obstétrica em itinerários abortivos. **Ciencia & saude coletiva**, v. 29, n. 9, p. e04552023, 2024.

GADAMER, H. G. **Verdade e Método I**: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 15 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2015.

GONZALEZ, R. Não é só um retrocesso, é um projeto de desmonte. Entrevista concedida a Viviane Tavares. **Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio**, 3 nov. 2022. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/nao-e-so-um-retrocesso-e-um-projeto-de-desmonte>. Acesso em: 23 set. 2024.

HAUM, N. D. A. P.; CARVALHO, M. D. Controle social do SUS: a saúde em região de fronteira em pauta. **Saúde e Sociedade**, v. 30, n. 4, p. e200350, 2021.

HIRANO, A. R.; PICCO, T. M.; PIMENTA, R. A.; BAGGIO, M. A. Continuidade do cuidado da criança na Atenção Primária à Saúde em região de fronteira. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 27, p. e220697, 2023.

HOLT, V. N.; PELEGRÍ, E.; HARDY, M. *et al.* Patient-perceived barriers to early initiation of prenatal care at a large, urban federally qualified health center: a mixed-methods study. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 24, p. 436, 2024.

HU, X.; ZHANG, L. Uteroplacental circulation in normal pregnancy and preeclampsia: Functional adaptation and maladaptation. **International Journal of Molecular Sciences**, v.

22, n. 16, p. 8622, 2021.

JORGE, H. M. F.; SILVA, R. M.; MAKUCH, M. Y. Humanized care in high-risk prenatal care: nurses' perceptions. **Rev Rene**. 2020;21: e44521.

KALAITZOPOULOS, D. R.; PANAGOPOULOS, A.; SAMANT, S.; GHALIB, N.; KADILLARI, J.; DANIILIDIS, A. Management of venous thromboembolism in pregnancy. **Thrombosis Research**, [S. l.], v. 211, p. 106-113, 2022.

KLEINMAN, A. **Patients and healers in the context of culture**: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry. Univ of California Press, 1980.

LIMA, L. T. P. L.; TOSO, B. R. G. O. Itinerário terapêutico de brasileiros na atenção primária na tríplice fronteira. **SEMINA: Ciências biológicas e da Saúde**, Londrina, v. 40, n. 1, p. 37-46, 2019.

LUZ, R. O.; PIESZAK, G. M.; ARRUÉ, A. M.; GOMES, G. C.; NEVES, E. T.; RODRIGUES, A. P. Itinerário terapêutico de famílias de crianças com necessidades especiais de saúde. **Revista Rede de Enfermagem do Nordeste**, Fortaleza, v. 20, e33937, 2019.

MACHADO, J. S. de A.; PENNA, C. M. de M. As políticas públicas de saúde e a fragmentação do corpo feminino em útero e peito. *Physis*: **Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, p. e320221, 2022.

MARTINS, D. C. *et al.* Assessment of the attributes of Primary Health Care with women of reproductive age. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 3, 2022.

MCLEAN, K.; CUSHMAN, M. Venous thromboembolism and stroke in pregnancy. **Hematology**, v. 2016, n. 1, p. 243–250, 2016.

MELLO, F. D.; VICTORA, C. G.; GONÇALVES, H. Saúde nas fronteiras: análise quantitativa e qualitativa da clientela do Centro Materno Infantil de Foz do Iguaçu, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 7, p. 2135–2145, 2015.

MENDES, C. R. A. Atenção à Saúde da Mulher na Atenção Básica: Potencialidades e Limites. **Ensaio e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde**, v. 20, n. 2, p. 65–72, 2016.

MENDONÇA, F. C. C. G. *et al.* Trombofilia e gravidez: significados atribuídos à intervenção medicamentosa com enoxaparina sódio no período grávida-puerperal. **Sete Editora**, [S. l.], pág. 35–50, 2024.

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: **Hucitec**, 2014.

MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 621-626, 2012.

MINAYO, M. C. S. O Desafio do conhecimento. **Pesquisa qualitativa em Saúde**. 13. Ed. São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro: Abrasco, 2013.

MORAIS, M. K. S. Caracterização de mulheres com perda gestacional recorrente acompanhadas no pré-natal de alto risco. **Rev Enferm Atenção Saúde**. 2024; 13(1): e202409.

MOROI, Ş. *et al.* Pregnancy-Related Thromboembolism—Current Challenges at the Emergency Department. **Journal of Personalized Medicine**, v. 14, n. 9, p. 926, 2024.

MORTELARO, K. P.; CIRELLI, F. J.; NARCHI, Z. N.; CAMPOS, E. A. Da Rede Cegonha à Rami: tensões entre paradigmas de atenção ao ciclo gravídico-puerperal. **Saúde em Debate**, [S. l.], v. 48, n. 140, p. e8152, 2024.

NAKATA, L. C.; FELTRIN, A. F. D. S.; CHAVES, L. D. P.; FERREIRA, J. B. B. Conceito de rede de atenção à saúde e suas características-chaves: uma revisão de escopo. **Escola Anna Nery**, v. 24, n. 2, p. e20190154, 2020.

NASCIMENTO, C. M. D. B.; MACHADO, A. M. N.; GUERRA, J. C. D. C.; ZLOTNIK, E.; CAMPÊLO, D. H. C.; KAUFFMAN, P.; WAKSMAN, H.; WOLOSKEWICZ, N.; PODGAEC, S.; HAMERSCHLAK, N. Consensus on the investigation of thrombophilia in women and clinical management. **Einstein (São Paulo)**, v. 17, n. 3, p. eAE4510, 2019.

NUNES, M. B. L. *et al.* Sentimentos da mulher frente a gestação de alto risco. **Enfermería Actual de Costa Rica**, n. 46, 2024.

OLIVEIRA, A. L. M. L.; MARQUES, M. A. Profilaxia de tromboembolismo venoso na gestação. **Jornal Vascular Brasileiro**, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 293-301, 2016.

OLIVEIRA, I. C. B.; SILVA, R. M. M.; FERREIRA, H.; FERRARI, R. A. P.; ZILLY, A. Influência de fatores epidemiológicos no seguimento e aparecimento de problemas puerperais. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 34, 2020.

OSORIO-DE-CASTRO, C. G. S. *et al.* Judicialização de medicamentos de alto custo no Brasil: uma revisão de escopo. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 35, p. e350309, 2025.

PANTOJA, G. X. *et al.* Experiências psicoemocionais de vítimas de violência obstétrica: revisão de escopo. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 15, 2025.

PEREZ, T. K. H. *et al.* Trombofilia em gestantes: importância da assistência de enfermagem. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 6, p. 3187-3201, 2024.

PICCO, T. M.; BAGGIO, M. A.; HIRANO, A. R.; CALDEIRA, S.; FERRARI, R. A. P. Cuidado em saúde à criança na atenção primária em região de fronteira. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20210104, 2022.

RIDDER, A.; GIORGIONE, V.; KHALIL, A.; THILAGANATHAN, B. Preeclampsia: the relationship between uterine artery blood flow and trophoblast function. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 20, n. 13, p. 3263, 2019.

ROSA, H.; CABRAL, C. S. Uma cidadania da fertilidade - as políticas de saúde da mulher como tecnologias de produção do sexo e do gênero. **Saúde e Sociedade**, v. 32, p. e220534pt, 2023.

ROVER, M. R. M. *et al.* Acesso a medicamentos de alto preço: desigualdades na organização e resultados entre estados brasileiros. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 5499-5508, 2021.

SANTOS, B. A.; MILBRATH, V. M.; FREITAS, V. L.; GABATZ, R. I. B.; VAZ, J. C. Rede De Apoio Social À Família Da Criança Com Paralisia Cerebral. **Revista Online de Pesquisa-Cuidado é fundamental**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 5, p. 1300-1306, 2019.

SILVA, N. E. K. e; SANCHO, L. G.; FIGUEIREDO, W. S. Entre fluxos e projetos terapêuticos: revisitando as noções de linha do cuidado em saúde e itinerários terapêuticos. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.l.], v. 21, n. 3, p. 843–852, 2016.

SILVA, V. M. *et al.* Letramento em saúde dos profissionais de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 22, p. 62315-62315, 2020.

SOARES, D. A. *et al.* Atenção Primária à Saúde abrangente: análise a partir do trabalho das equipes de Saúde da Família frente às doenças crônicas. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 34, p. e34015, 2024.

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN. **Nota técnica para organização da rede de atenção à saúde com foco na atenção primária à saúde e na atenção ambulatorial especializada – saúde da mulher na gestação, parto e puerpério**. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein; Ministério da Saúde, 2019. 56 p. il.

SORATTO, J.; PIRES, D. E.; CABRAL, I. E.; LAZZARI, D. D.; WITT, R. R.; SIPRIANO, C. A. de S. A creative and sensitive way to research. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 67, n. 6, p. 994-9, 2014.

SOUSA, A. A.; OLIVEIRA, D. R.; DAMASCENO, S. S.; QUIRINO, G. S.; PINTO, A. G. A.; CRUZ, R. S. B. L. C. Representações sociais sobre o planejamento reprodutivo entre mulheres em gravidez não planejada. **Revista de Enfermagem UERJ**, v. 32, n. 1, e79100, 2024.

STARFIELD, B. **Atenção Primária**: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: Unesco, 2002. 725 p.

TAO, J. J.; ADURTY, S.; D'ANGELO, D.; De SANCHO, M. T. Management and outcomes of women with antiphospholipid syndrome during pregnancy. **Journal of Thrombosis and Thrombolysis**, v. 55, n. 4, p. 751-759, 2023.

TSIKOURAS, P.; DEFTEREOU, T.; ANTHOULAKI, X.; BOTHOU, A.; CHALKIDOU, A.; CHRISTOFORIDOU, A.; *et al.* Thrombophilia and pregnancy: diagnosis and management. In: Embolic Diseases - Evolving Diagnostic and Management Approaches. **IntechOpen**, 2020.

VELOSO, C.M.; MARTINS, M.B., PEDREIRA, N.P.; SANTOS, E.P.; AZEVEDO JR, W. S.; NASCIMENTO, V. G.; *et al.* Práticas de enfermagem na coordenação do cuidado na atenção primária à saúde. **Enferm Foco**. 2024;15(Supl 1):e-202405SUPL1.

VIEIRA, Fabiola Sulpino *et al.* **Pesquisa Assistência Farmacêutica no SUS: uma análise do gasto em medicamentos de estados e municípios participantes (2019-2023)** Brasília, DF: Ipea,

2025. 65 p.: il. (Texto para Discussão, n. 3120).

VINUTO, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. **Temáticas**, v. 22, n. 44, p. 203-220, 2014.

VOICU, D. I.; MUNTEANU, O.; GHERGHICEANU, F.; ARSENE, L. V.; BOHILTEA, R. E.; GRADINARU, D. M.; CIRSTOIU, M. M. Maternal inherited thrombophilia and pregnancy outcomes. **Experimental and Therapeutic Medicine**, v. 20, n. 3, p. 2411-2414, 2020.

WANG, X.; MA, Y.; HUI, X.; *et al.* Oral direct thrombin inhibitors or oral factor Xa inhibitors versus conventional anticoagulants for the treatment of deep vein thrombosis. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 2023, n. 4, p. CD010956, 2023.

WAWRUSIEWICZ-KURLONEK, N.; KRĘTOWSKI, A. J.; POSMYK, R. Frequency of thrombophilia associated genes variants: population-based study. **BMC Medical Genetics**, v. 21, p. 198, 2020.

XAVIER, G. G. *et al.* As influências da territorialização no acesso aos serviços de saúde pelas populações de fronteira: revisão sistemática. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e32611831176-e32611831176, 2022.

ZARTH, M. D.; FERNÁNDEZ, P. A.; BAGGIO, M. A.; ZILLY, A.; GAMARRA, C. J.; SILVA, R. M. M. Cuidado transcultural de enfermagem à mulher imigrante na gestação e parto: experiências e vulnerabilidades. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 45, e20230161, 2024.

APENDICE I – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA

1. PERFIL DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTICIPANTES:
Unidade de Saúde de referência:
UBS:
Plano de saúde particular? Qual?
No dia da entrevista encontra-se gestante? Se sim, de quantas semanas?
Idade:
Escolaridade: ☐ Não alfabetizada ☐ Ensino fundamental incompleto ☐ Ensino Fundamental completo ☐ Ensino Médio incompleto ☐ Ensino médio completo ☐ Ensino Superior incompleto ☐ Ensino Superior completo
Ocupação:
Renda salarial: ☐ Menos de 1 salário-mínimo ☐ Até 1 salário-mínimo ☐ Até 2 salários-mínimos ☐ Até 3 salários-mínimos ☐ Mais de 3 salários-mínimos
2. DADOS RELACIONADOS AO PERFIL GESTACIONAL
Antecedentes Obstétricos: nº ☐ Parto natural nº ☐ Parto cesáreo nº ☐ Aborto Fase gestacional do(s) aborto(s):
Você usava algum método contraceptivo antes de engravidar? Se sim, qual?
Com quantas semanas descobriu que estava grávida?
Referente a última gestação você teve alguma complicação gestacional? Em qual trimestre?
3. DADOS RELACIONADOS AO ITINERÁRIO TERAPEUTICO
Qual orientação médica você teve depois da perda gestacional?
Foi te explicado o motivo da perda gestacional?
O médico te encaminhou para realizar exames de investigação para trombofilia?
Se sim, quais exames foram prescritos e quais conseguiu fazer?
Por qual motivo não conseguiu fazer?
O médico te encaminhou para um especialista?
Quem te orientou a solicitar o medicamento na 9ª Regional de Saúde?
Você conseguiu receber a Enoxaparina sódica? Se sim, com quantas semanas?
Caso não tenha conseguido receber a enoxaparina sódica, foi te explicado o motivo?

APENDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

UNIVERSIDADE DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – COLETA DE DADOS VIRTUAL

Convidamos o a Sra. para participar como voluntária da pesquisa Itinerário Terapêutico de gestantes que demandam uso de anticoagulante em região de fronteira, que está sob a responsabilidade do pesquisador Adriana Zilly (Avenida Maceió, 1277, Foz do Iguaçu, PR. CEP: 85869-657, Tel: (45) 999272200, e-mail: adriana.zilly@unioeste.br).

Também participam desta pesquisa: Meirieli Íside Mattos Carvalho.

Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde em participar desse estudo, pedimos que assinale a opção de “Aceito participar da pesquisa” no final desse termo.

A senhora estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Descrição da pesquisa e esclarecimento da participação: esta pesquisa, buscará descrever o Itinerário terapêutico (o caminho percorrido) das gestantes que necessitam o uso de tratamento com anticoagulante (enoxaparina), um medicamento de alto custo, disponibilizado pela 9ª Regional de saúde de Foz do Iguaçu. Entretanto, enfrentam dificuldades no recebimento por não se encaixarem aos critérios clínicos e laboratoriais estabelecidos pelo Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêutica (PCDT) do estado do Paraná. Para tal, a senhora está sendo convidada a responder uma entrevista de modo presencial ou por ligação de áudio/vídeo via aplicativo *WhatsApp*®. Seja qual for a forma de participação mais conveniente por escolha da participante exigem a autorização mediante preenchimento deste termo na opção “Aceito participar da pesquisa” e poderão ocorrer conforme sua disponibilidade com agendamento, dia e horário, de escolha.

RISCOS: Os riscos estão relacionados aos desconfortos e constrangimentos que podem acontecer durante a entrevista ao lembrar e referir situações vivenciadas no seu processo, no entanto, a entrevistado terá a liberdade de não responder e parar a entrevista se assim desejar. Em caso de necessidade, o pesquisador responsável providenciará atendimento imediato, integral e gratuito. Ademais, pode estar relacionado a perda/vazamento de dados coletados de forma virtual, entretanto, será preservado a segurança destes dados mediante armazenamento em pastas de acesso restrito ao pesquisador, também informamos seu direito a possível indenização, na ocorrência de danos relacionados à participação na pesquisa, por parte do pesquisador.

BENEFÍCIOS: Os resultados desta pesquisa não trarão benefícios diretos para as gestantes do estudo neste momento, mas que a participação será extremamente importante para conhecermos o Itinerário terapêutico das gestantes que necessitam de anticoagulação, mas não conseguem ser contempladas pelo direito de receber o medicamento de alto custo por não conseguirem comprovar um diagnóstico conclusivo de trombofilia e/ou pelos critérios clínicos. Nós poderemos obter informações importantes sobre como ocorre seguimento da saúde da gestante com perdas gestacionais e quadros que se assemelham aos de trombofilia no âmbito da atenção primária, bem como, compreender quais as orientações e encaminhamentos para especialistas

recebem essas gestantes e os fatores que auxiliam ou dificultam o mesmo, o que contribui em muito para a discussão sobre a melhoria da atenção e acompanhamentos, subsidiando ações de Educação Permanente, delineamentos e qualificação dos profissionais do seguimento da atenção primária sobre gestação de alto risco. Acredita-se que essas medidas contribuirão para redução da mortalidade materno-infantil por causas evitáveis como trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal, perdas gestacionais de repetição, embolia pulmonar e óbito fetal intraútero.

Esclarecemos que os participantes dessa pesquisa têm plena liberdade de se recusar a participar do estudo e que esta decisão não acarretará penalização por parte dos pesquisadores. Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa, ficarão armazenados em computador pessoal, sob a responsabilidade da pesquisadora responsável, no endereço acima informado, pelo período de mínimo 5 anos após o término da pesquisa.

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial.

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, a senhora poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UNIOESTE – Cascavel, no endereço: **(Rua Universitária, 1619 – Universitário, Cascavel - Paraná, Brasil, CEP: 85819-110, Tel.: (45) 3220-3092 (ramal 3092)- e-mail: cep.prppg@unioeste.br).**

(Assinatura do Pesquisador)

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO(A)

Eu, _____, CPF _____, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo, Itinerário terapêutico de gestantes que demandam uso de anticoagulante em Região de Fronteira, como voluntária. Fui devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento para participar da pesquisa.

- () Aceito Participar da pesquisa
() Não aceito participar da pesquisa

ANEXO I – TERMO DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Itinerário Terapêutico de Gestantes que demandam uso de Anticoagulante em Região de Fronteira

Pesquisador: Adriana Zilly

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 83946524.8.0000.0107

Instituição Proponente: CCB Colegiado de Ciências Biológicas

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.200.210

Apresentação do Projeto:

Projeto de Mestrado que busca descrever o itinerário terapêutico de gestantes que demandam tratamento com anticoagulante em um município de fronteira internacional, tendo como participantes gestantes que demandam uso de enoxaparina sódica pela 9ª Regional de Saúde.

Apresenta-se bem estruturado, com a problemática apresentada na introdução, sem hipótese delimitada, com justificativa e relevância do estudo, objetivos delimitados, passíveis de serem alcançados de acordo com a metodologia e o cronograma de atividades apresentado.

Descreve detalhadamente a forma de coleta e análise dos dados, critérios de inclusão e exclusão de participantes, assim como apresenta os termos de apresentação obrigatória necessários a apreciação deste CEP, estando em conformidade com as normas regulamentadoras de pesquisa com seres humanos.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Descrever o itinerário terapêutico de gestantes que demandam tratamento com anticoagulante em um município de fronteira internacional.

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Telefone: (45)3220-3092

Município: CASCAVEL

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prpgg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.200.210

Objetivo Secundário:

Descrever o perfil sociodemográfico e obstétrico das participantes;

Investigar como se estrutura o itinerário percorrido pelas gestantes que necessitam de terapia anticoagulante em um município de fronteira internacional;

Analisar a partir da percepção das gestantes os impactos e desafios do itinerário estabelecido;

Analisar o itinerário terapêutico percorrido pelas gestantes que necessitam de terapia anticoagulante com medicamento de alto custo (i.e., EP) em um município de fronteira internacional.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Em conformidade

Riscos:

Os riscos estão relacionados aos desconfortos e constrangimentos que podem acontecer durante a entrevista ao lembrar e referir situações vivenciadas no seu processo, no entanto, a entrevistado terá a liberdade de não responder e parar a entrevista se assim desejar. Em caso de necessidade, o pesquisador responsável providenciará atendimento imediato, integral e gratuito. Ademais, pode estar relacionado a perda/vazamento de dados coletados de forma virtual, entretanto, será preservado a segurança destes dados mediante armazenamento em pastas de acesso restrito ao pesquisador, também informamos seu direito a possível indenização, na ocorrência de danos relacionados a participação na pesquisa, por parte do pesquisador.

Benefícios:

Os resultados desta pesquisa não trarão benefícios diretos para as gestantes do estudo neste momento, mas que a participação será extremamente importante para conhecermos o Itinerário terapêutico das gestantes que necessitam de anticoagulação, mas não conseguem ser contempladas pelo direito de receber o medicamento de alto custo por não conseguirem comprovar um diagnóstico conclusivo de trombofilia e/ou pelos critérios clínicos. Nós poderemos obter informações importantes sobre como ocorre seguimento da saúde da gestante com perdas gestacionais e quadros que se assemelham aos de trombofilia no âmbito da atenção primária, bem como, compreender quais as orientações e encaminhamentos para

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

Página 02 de 05

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.200.210

especialistas recebem essas gestantes e os fatores que auxiliam ou dificultam o mesmo, o que contribui em muito para a discussão sobre a melhoria da atenção e acompanhamentos, subsidiando ações de Educação Permanente, delineamentos e qualificação dos profissionais do seguimento da atenção primária sobre gestação de alto risco. Acredita-se que essas medidas contribuirão para redução da mortalidade materno-infantil por causas evitáveis como trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal, perdas gestacionais de repetição, embolia pulmonar e óbito fetal intraútero.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, a partir das entrevistas com mulheres gestantes que demandam o uso de enoxaparina sódica pela 9ª Regional de Saúde. A população envolvida será selecionada por conveniência e submetida a uma entrevista semiestruturada com um roteiro específico elaborado para esta pesquisa.

Serão adotados como critérios de inclusão: estar gestante no momento da solicitação dos medicamentos na 9ª Regional, ter laudo com recomendação médica, ser residente em Foz do Iguaçu, PR ou no Paraguai.

Como critérios de exclusão indica-se ser menor de 18 anos de idade e possuir algum problema de saúde que impeça a sua participação.

As entrevistas serão conduzidas no local e dia mais conveniente para as entrevistadas, seja presencialmente, por telefone ou de modo online (chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp®), e as participantes serão identificadas por códigos, garantindo assim o anonimato. As entrevistas semiestruturadas abordarão não apenas questões relacionadas ao IT, mas também aspectos relacionados ao perfil sociodemográfico e gestacional das participantes.

A análise dos dados será conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo (AC), a fim de explorar os resultados obtidos.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Anexo I - Formulário de pesquisa - anexo

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

CEP: 85.819-110

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.200.210

Anexo II - Autorização da instituição co-participante - anexado
Anexo III - Declaração de uso de dados - anexado
Anexo IV - Declaração de pesquisa não iniciada - anexada
Folha de Rosto - anexada
Projeto de Pesquisa - anexado
Instrumento de coleta de dados - anexado
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - anexado

Recomendações:

Apresentar relatório final ao CEP em até 30 dias após a conclusão da mesma.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências ou inadequações.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2406731.pdf	15/10/2024 20:42:24		Aceito
Outros	Formulario_CEP_assinado.pdf	15/10/2024 20:40:57	MEIRIELI ISIDE MATTOS CARVALHO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_Meirieli_VERSAO_CEP_instrumento.pdf	15/10/2024 20:38:45	MEIRIELI ISIDE MATTOS CARVALHO	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto_MEIRIELI_assinada.pdf	15/10/2024 11:50:15	MEIRIELI ISIDE MATTOS CARVALHO	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	termo_de_anuencia_institucional_NONA_RegionalFOZ_ASSINADO.pdf	15/10/2024 11:20:03	MEIRIELI ISIDE MATTOS CARVALHO	Aceito
Declaração de Pesquisadores	DECLARACAO_DE_PESQUISA_NAO_INICIADA_IT_ASSINADA.pdf	15/10/2024 11:16:46	MEIRIELI ISIDE MATTOS CARVALHO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_IT.pdf	15/10/2024 11:13:52	MEIRIELI ISIDE MATTOS CARVALHO	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.200.210

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 01 de Novembro de 2024

Assinado por:

Fausto José da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

Página 05 de 05